

le oscuridad

moria de la locura

William Styron

William Styron

**Visible oscuridad:
Una memoria de la locura**

1989

Título original: **Darkness Visible: A Memoir Of Madness**

Autor: **William Styron [1925/2006]**

País de publicación: **U.S.A.**

Traducida por: **Pedro E. Yamín**

Fecha de traducción: **Julio 2014**

Ubicación original:

<https://archive.org/details/DarknessVisiblewilliamStyron>

Libre de derechos según consta en la siguiente declaración:

Creative Commons License Deed

Reconocimiento 3.0 Unported (CC BY 3.0)



pedroeyamin@gmail.com

Contenido

Nota del autor	iii
I.....	2
II	14
III	20
IV	25
V	36
VI.....	42
VII.....	48
VIII	50
IX.....	55
X	59
Nota del traductor	62

A Rose

Nota del autor

Este libro comenzó como una conferencia dada en Baltimore en mayo de 1989 en un simposio sobre trastornos afectivos patrocinado por el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Ampliado, el texto se convirtió en un ensayo publicado en diciembre de ese año en la revista Vanity Fair; yo había previsto inicialmente comenzar con una narración de un viaje que hice a París — un viaje que tenía un significado especial para mí en términos de desarrollo de la enfermedad depresiva que yo había sufrido. Pero a pesar de la excepcionalmente amplia cantidad de espacio que la revista me brindó, había un límite inevitable, y tuve que descartar esta parte en favor de otros temas que quería tratar. En la presente versión, esa sección ha sido restituida a su lugar original. A excepción de algunos cambios relativamente menores y adiciones, el resto del texto permanece como apareció en un principio.

W.S.

*Porque me sucedió lo que más temía
y me sobrevino algo terrible.
¡No tengo calma, ni tranquilidad, ni sosiego,
sólo una constante agitación!*
Job

I

En París en una noche fría a finales de octubre de 1985 obtuve plena conciencia de que esa lucha con el desorden en mi mente —una lucha en que me había empeñado desde hacía varios meses— podría tener un desenlace fatal.

El momento de la revelación vino cuando el coche en el que viajaba se desplazaba por una calle resbalosa bajo la lluvia no muy lejos de los Champs Elysees y se deslizó más allá de un letrero de neón brillando débilmente que decía *HOTEL WASHINGTON*. No había visto ese hotel en casi treinta y cinco años, desde la primavera de 1952, cuando durante varias noches se convirtió en mi primer lugar de descanso parisino. En los primeros meses de mi *Wanderjahr*,¹ yo había llegado a París en tren desde Copenhague, y aterricé en el Hotel Washington por la determinación caprichosa de un agente de viajes de Nueva York. En aquellos días, el hotel era una de las muchas posadas húmedas, sencillas, hechas para los turistas, principalmente estadounidenses, de medios muy modestos como yo —chocando con nerviosismo por primera vez con los franceses y sus hábitos graciosos. Siempre recordaría cómo el bidet exótico, posicionado sólidamente en el monótono dormitorio, y el baño lejos en el pasillo mal iluminado, prácticamente definía el abismo entre la cultura gala y la anglosajona. Pero me quedé en el Washington por un corto tiempo. A los pocos días fui instado a salir del lugar por algunos jóvenes amigos americanos recién conocidos que me instalaron en un hotel, incluso más sospechoso pero más colorido en Montparnasse, muy cerca de Le Dome y otros lugares de reunión debidamente literarios. (A la mitad de mis veintes, había recién publicado mi primera novela y era una celebridad, aunque una de muy bajo rango ya que pocos de los americanos en París habían oído hablar de mi libro, y mucho menos leído.) Con los años el hotel Washington

¹ Año dedicado a viajar para adquirir experiencia (NdT)

desapareció gradualmente de mi conciencia.

Reapareció, sin embargo, esa noche de octubre, cuando pasé por la fachada de piedra gris bajo la llovizna, y el recuerdo de mi llegada de hace muchos años comenzó a regresar, haciéndome sentir que había dado fatalmente un giro completo. Recuerdo diciéndome a mí mismo que cuando me fui de París a Nueva York a la mañana siguiente sería para siempre. Estaba conmovido por la certeza con que acepté la idea de que nunca volvería a ver Francia, lo mismo que nunca recuperaría la lucidez que se me estaba escapando a una velocidad aterradora.

Sólo unos días antes había llegado a la conclusión de que sufría una enfermedad depresiva grave y fracasaba sin remedio en mis esfuerzos para hacerle frente. No me animaba la ocasión festiva que me había llevado a Francia. De las muchas manifestaciones terribles de la enfermedad, tanto físicas como psicológicas, una sensación de odio a mí mismo o, poniéndolo menos categóricamente, un fracaso de la autoestima, es uno de los síntomas más universalmente experimentados, y yo había sufrido cada vez más de una sensación general de inutilidad a medida que la enfermedad había progresado.

Mi fría tristeza, por tanto, resultaba tanto más irónica porque yo había volado en un viaje apresurado de cuatro días a París para recibir un premio que debería haber restaurado impecablemente mi ego. A principios de ese verano recibí la noticia de que había sido elegido para recibir el *Prix Mondial Cino del Duca*, que se otorga anualmente a un artista o un científico cuya obra refleje temas o principios de cierto "humanismo". El premio fue establecido en memoria de Cino del Duca, un inmigrante italiano que amasó una fortuna, justo antes y después de la Segunda Guerra Mundial por la impresión y distribución de revistas baratas, principalmente cómics, aunque más tarde tras la diversificación en publicaciones de calidad se convirtió en propietario del periódico *Paris-Jour*. También produjo películas y era dueño de un caballo de carrera prominente, disfrutando del placer de

tener muchos premios en Francia y en el extranjero. Persiguiendo satisfacciones culturales más nobles, se convirtió en un reconocido filántropo y en el camino fundó una firma de publicación de libros que comenzó a producir obras de calidad literaria (por casualidad, mi primera novela, *Tendidos en la oscuridad*, era una de las ofertas de Del Duca en una traducción llamada *Un lit de tenebres*), pero al momento de su muerte, en 1967 esta casa, *Editions Month Ales*, se convirtió en una entidad importante de un imperio múltiple que era lo suficientemente rico y prestigioso para tener poca memoria de sus orígenes como productora de cómics; la viuda de del Duca, Simone, creó una fundación que tiene como función principal la concesión anual del premio mencionado.

El *Prix Mondial Cino del Duca* ha adquirido prestigio en Francia —una nación gratamente aficionada a la entrega de premios a la cultura— no sólo por su eclecticismo y la distinción demostrada en la elección de sus receptores, sino por la generosidad del premio en sí, que ese año ascendió a aproximadamente 25.000 dólares. Entre los ganadores en los últimos veinte años han estado Konrad Lorenz, Alejo Carpentier, Jean Anouilh, Ignazio Silone, Andrei Sajarov, Jorge Luis Borges y un estadounidense, Lewis Mumford. (Ninguna mujer hasta el momento, las feministas tomen nota.) Como estadounidense, me pareció especialmente difícil no sentirme honrado por la inclusión en esta compañía.

Mientras que el dar y recibir premios por lo general induce, desde cualquier punto de vista, a una dañina rebelión de la falsa modestia, la maledicencia, la auto-tortura y la envidia, mi opinión es que ciertos premios, aunque no sean necesarios, pueden ser muy agradable de recibir. El Premio del Duca fue para mí tan francamente agradable que cualquier autoexamen intensivo parecía tonto, así acepté agradecido, escribiendo en respuesta que iba a honrar el razonable requisito de estar presente para la ceremonia. En ese momento tenía ganas de un viaje tranquilo, no una vuelta apresurada. Si yo

hubiera sido capaz de prever mi estado de ánimo en cuanto la fecha de la adjudicación se aproximaba, no lo habría aceptado de ninguna manera.

La depresión es un trastorno del estado de ánimo, tan misteriosamente doloroso y esquivo en la forma de mostrarse —al intelecto intermediario— hasta el punto que llega a ser indescriptible. Por lo tanto, sigue siendo casi incomprensible para los que no lo han experimentado en su modalidad extrema, aunque la melancolía, "la tristeza" que la gente atraviesa de vez en cuando y asocian con la molestia general de la existencia cotidiana, es de tal prevalencia que da a muchas personas un indicio de la enfermedad en su forma catastrófica. Pero en el momento sobre el que escribo yo había descendido mucho más allá de ese familiar y manejable abatimiento.

En París, puedo verlo ahora, yo estaba en una etapa crítica del desarrollo de la enfermedad, situado en una estación de manera ominosa entre las emocionantes agitaciones previas al verano y el desenlace casi violento de diciembre, que me envió al hospital. Más adelante voy a tratar de describir la evolución de esta enfermedad, desde sus primeros orígenes hasta mi eventual hospitalización y recuperación, pero el viaje de París ha conservado un sentido notable para mí.

El día de la ceremonia, que se llevaría a cabo al mediodía, seguido por un almuerzo formal, me desperté a media mañana en mi habitación del Hotel Pont-Royal pensando que me sentía razonablemente bien, y pasé la buena noticia a mi esposa, Rose. Ayudado por el Halcion, tranquilizante menor, había logrado derrotar mi insomnio y dormir unas pocas horas. Así que estaba de buen humor. Pero tal débil alegría era un disfraz habitual que sabía significaba muy poco, pues estaba seguro de sentirme horrible antes del anochecer. Yo había llegado a un punto en el que estaba monitoreando cuidadosamente cada fase de mi deterioro. Mi aceptación de la enfermedad vino tras varios meses de negación en la que, al principio, yo había atribuido el malestar y la inquietud y repentinos ataques de ansiedad a la

abstinencia del alcohol; había abandonado bruscamente el whisky y todos los otros intoxicantes en junio.

Mientras empeoraba mi clima emocional leí cierta cantidad sobre el tema de la depresión, tanto en libros adaptados para el profano y en trabajos profesionales de más peso, incluyendo la biblia de los psiquiatras, el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría). A lo largo de gran parte de mi vida me he visto obligado, quizás imprudentemente, a convertirme en un autodidacta en medicina, y he acumulado conocimientos médicos superiores al promedio de los aficionados, (de los cuales muchos de mis amigos, sin duda imprudentemente, a menudo han diferido), por lo que fue una sorpresa para mí, saber que estaba cerca de ser un ignorante total sobre la depresión, que puede ser un asunto médico tan serio como la diabetes o el cáncer. Muy probablemente, como un depresivo incipiente, había siempre subconscientemente rechazado o ignorado el conocimiento adecuado, este caló demasiado profundo en el hueso psíquico, y lo hice a un lado como un agregado indeseable a mi almacén de información.

En todo caso, durante las pocas horas en que el propio estado depresivo aflojaba lo suficiente como para permitirme el lujo de la concentración, recientemente había llenado este vacío con bastante extensa lectura y había conocido muchos hechos fascinantes e inquietantes, a los cuales, sin embargo, no podría hallarles un uso práctico. Las autoridades más honestas plantean llanamente el hecho de que la depresión grave no es fácilmente tratable. A diferencia, digamos, de la diabetes, donde las medidas adoptadas inmediatamente para reorganizar la adaptación del organismo a la glucosa pueden revertir drásticamente un proceso peligroso y ponerla bajo control; la depresión en sus etapas críticas no posee remedios disponibles rápidamente: el fracaso en el alivio inmediato es uno de los factores más angustiantes del trastorno como este se revela a la víctima, y contribuye a situarla de lleno en la categoría de las

enfermedades graves. Excepto en aquellas enfermedades estrictamente catalogadas como malignas o degenerativas, esperamos algún tipo de tratamiento y eventual mejora, mediante medicamentos o terapia física o dieta o cirugía, con una progresión lógica desde el alivio inicial de los síntomas hasta la cura final. Es alarmante que el lego que sufre de depresión mayor, dando un vistazo a algunos de los muchos libros actualmente en el mercado, encuentra mucho sobre teoría y sintomatología y muy poco que legítimamente sugiera la posibilidad de un rápido rescate. Los que afirman una salida fácil son simplistas y muy probablemente fraudulentos. Hay obras populares decentes que inteligentemente señalan el camino hacia el tratamiento y la cura, demostrando cómo ciertas terapias —psicoterapia o farmacológicas, o una combinación de éstas— pueden de hecho restaurar la salud de la gente a todos los casos excepto en los más persistentes y devastadores; pero los libros más sabios, revelan la dura verdad de que las depresiones graves no desaparecen de la noche a la mañana. Todo esto pone de relieve una esencial aunque difícil realidad, que creo es necesario destacar al principio de mi propia crónica: la enfermedad de la depresión sigue siendo un gran misterio. Ha cedido sus secretos a la ciencia mucho más renuientemente que muchos otros males graves que nos azotan. El sectarismo intenso y a veces cómicamente estridente que existe en la psiquiatría de nuestros días —el cisma entre los creyentes en la psicoterapia y los partidarios de la farmacología— se asemeja a las disputas médicas del siglo XVIII (de sangrar o no sangrar) y casi define en sí misma la naturaleza inexplicable de la depresión y la dificultad de su tratamiento. Como un clínico en este campo me dijo con honestidad y, creo yo, con una sorprendente y diestra analogía: *«Si se compara nuestro conocimiento con el descubrimiento de América por Colón, el continente sería aún desconocido; todavía estaríamos en esa pequeña isla en las Bahamas».*

En mis lecturas había aprendido, por ejemplo, que al

menos en un aspecto mi caso era atípico. La mayoría de las personas que comienzan a sufrir la enfermedad están decaídas por la mañana, con efectos tan maléficos que son incapaces de salir de la cama. Se sienten mejor a medida que avanza el día. Pero mi situación era justo al revés. Mientras que yo era capaz de levantarme y funcionar casi con normalidad durante la primera parte del día, empezaba a sentir el inicio de los síntomas a media tarde o un poco después —la tristeza crecía en mí, una sensación de temor y de alienación y, por encima de todo, una ansiedad sofocante. Sospecho que básicamente es indiferente si uno sufre más por la mañana o por la tarde: si estos estados de insoportable casi parálisis son similares, ya que probablemente lo son, la cuestión del tiempo parece ser meramente académica. Pero fue, sin duda, el cambio en mi rutina diaria de síntomas lo que me permitió esa mañana en París proseguir sin contratiempos, sintiéndome más o menos dueño de mí mismo, hasta el palacio gloriosamente adornado en la orilla derecha, que alberga la Fundación Cino del Duca. Allí, en un salón de estilo rococó, fui galardonado con el premio ante un pequeño grupo de personajes de la cultura francesa. Pronuncié mi discurso de aceptación con lo que sentía era aplomo pasable, afirmando que donaba la mayor parte del dinero del premio para varias organizaciones que fomentan la buena voluntad entre Francia y Estados Unidos, incluyendo el Hospital Americano de Neuilly. Pero había un límite en mi altruismo (esto dicho en broma) y así esperaba que no se tomaría mal si reservaba una pequeña parte para mí mismo.

Lo que no había dicho, y que no era una broma, era que la cantidad que estaba reteniendo era para pagar dos boletos para el día siguiente en el Concorde, para poder volver rápidamente con Rose a los Estados Unidos, donde sólo unos pocos días antes había hecho una cita para ver a un psiquiatra. Por razones que estoy seguro tenían que ver con la renuencia a aceptar la realidad de que mi mente se estaba disolviendo, había evitado buscar ayuda psiquiátrica durante las últimas semanas,

mientras mi malestar se intensificaba. Pero yo sabía que no podía retrasar la confrontación indefinidamente, y cuando finalmente me puse en contacto por teléfono con un terapeuta muy recomendado, me animó a hacer el viaje a París, y me dijo que me iba a ver tan pronto como regresara. Necesitaba volver, y rápido.

A pesar de la evidencia de que yo estaba en serias dificultades, quería conservar la visión optimista. Gran parte de la literatura disponible acerca de la depresión es, como digo, alegremente optimista, extendiendo garantías de que casi todos los estados depresivos se estabilizan o revierten con tal de encontrar el antidepresivo adecuado; el lector es, por supuesto, arrastrado fácilmente por promesas de rápida mejoría. En París, como se deduce de mis anteriores comentarios, tenía una necesidad de que el día terminara ya, y sentía urgencia de volar a Estados Unidos y a la oficina del médico, quien alejaría mi malestar con sus medicamentos milagrosos. Recuerdo ahora ese momento con claridad, y no puedo creer que poseyera tal esperanza ingenua, o que pudiera haber sido tan inconsciente de la dificultad y del peligro que me esperaba.

Simone Del Duca, una mujer de largo cabello oscuro, de maneras majestuosas, estaba comprensiblemente incrédula al principio, y luego enfureció, cuando después de la ceremonia de presentación le dije que no podía reunirme con ella en el almuerzo, que se celebraba arriba en la gran mansión, junto con una docena de miembros de la Academia Francesa, que me había elegido para el premio. Mi excusa fue rotunda e ingenua; le dije que me había citado para almorzar en un restaurante con mi editor francés, Françoise Gallimard. Por supuesto, esta decisión de mi parte era indignante; me habían anunciado meses antes, y a todos los demás interesados, que un almuerzo —además, un almuerzo en mi honor— era parte de la celebración del día. Pero mi comportamiento era realmente el resultado de la enfermedad, que había progresado lo suficiente para producir algunas de sus señas de identidad más famosas y

sinietras: confusión, falta de concentración mental y olvido. En una etapa posterior, toda mi mente estaría dominada por desconexiones anárquicas; como he dicho, ahora había algo que se asemejaba a la bifurcación del estado de ánimo: la lucidez en las primeras horas del día, tornándose en oscuridad en la tarde y la noche. Debió haber sido durante la nebulosa distracción de la noche anterior que hice la cita para almorzar con François Gallimard, olvidando mis obligaciones con el Duca. Esa decisión continuó dominando completamente mi pensamiento, creando en mí tal obstinada determinación que fui capaz de ese insultante desprecio hacia la digna Simone del Duca.

«*Alors!*» —exclamó, y su rostro se sonrojó furiosamente mientras giraba en un majestuoso cambio de actitud, «*au... revoir!*» De repente, me quedé pasmado, aturdido con horror por lo que había hecho. Imaginé una mesa en la que estaba sentada la anfitriona y la Academia Francesa, y el invitado de honor en *La Coupole*. Imploré a la asistente de la señora, una mujer con gafas con una carpeta y una cenicienta, mortificada expresión, para tratar de enmendarme: que todo había sido un tremendo error, una confusión, un *malentendu*. Y entonces solté algunas palabras que en toda una vida de equilibrio general, y bajo la creencia de suficiencia en la inquebrantabilidad de mi salud psíquica, me habían impedido sospechar que jamás podría pronunciar; me quedé helado al oírme hablarles como si fuera un perfecto desconocido para mí mismo. «Estoy enfermo —dije—, un *probleme psychiatrique*». Madame del Duca fue magnánima al aceptar mi disculpa y el almuerzo transcurrió sin mayor presión, aunque no podía librarme por completo de la sospecha, mientras charlábamos con cierta rigidez, que mi benefactora todavía estaba preocupada por mi conducta y me creía un caso raro. El almuerzo fue muy largo, y cuando terminó, me sentía entrar en las sombras de la tarde con su invasiva ansiedad y temor. Un equipo de televisión de uno de los canales nacionales esperaba (me había olvidado también de ellos), listo para llevarme al Museo Picasso inaugurado

recientemente, donde se suponía que debía ser filmado mirando las exposiciones y el intercambio de comentarios con Rose. Esto resultó ser, como yo sabía que lo haría, no un paseo fascinante, sino una exigente lucha, una prueba importante.

En el momento en que llegamos al museo, después de haber luchado con mucho tráfico, ya eran más de las cuatro y mi cerebro había comenzado a sufrir el asedio acostumbrado: el pánico y la dislocación; la sensación de que mis procesos mentales estaban siendo engullidos por un tóxico y la marea innombrable que borra cualquier respuesta placentera al mundo de los vivos. Esto es para decir, más específicamente, que en lugar de placer —ciertamente en lugar del placer que debería estar teniendo en esta suntuosa exposición del brillante genio— estaba sintiendo en mi mente una sensación de similar intensidad, pero indescriptiblemente opuesta, de dolor real. Esto me lleva a referirme de nuevo a la naturaleza evasiva de tal angustia.

Que el uso de la palabra *indescriptible* no es fortuito, ya que debe enfatizarse que si el dolor fuera fácilmente descriptible la mayor parte de los innumerables enfermos de esta antigua aflicción habría sido capaz de explicar con confianza para sus amigos y seres queridos (incluso sus médicos), algunas de las dimensiones reales de su tormento, y tal vez obtener una comprensión que ha sido en general deficiente. Tal incomprensión ha sido por lo general debido no a un fallo de la simpatía, sino a la incapacidad básica de las personas sanas de imaginar una forma de tormento tan ajeno a la experiencia cotidiana. En cuanto a mí, el dolor está más estrechamente vinculado al ahogamiento o la sofocación, pero incluso estas imágenes son totalmente imprecisas. William James, quien luchó contra la depresión durante muchos años, renunció a la búsqueda de una representación adecuada, lo que implica su casi imposibilidad cuando escribió en *Las variedades de la experiencia religiosa*: «Es una angustia positiva y activa, una especie de neuralgia psíquica totalmente desconocida a la vida

normal».

El dolor persistió durante mi visita al museo y llegó a un crescendo en las horas siguientes, cuando, de vuelta en el hotel, me quedé en la cama mirando el techo, casi inmovilizado y en un trance de malestar supremo. El pensamiento racional estaba ausente de mi mente en ese momento, llamémosle *trance*. No se me ocurre ninguna palabra más apropiada para este estado del ser, un estado de desamparado estupor en el que la cognición es reemplazada por la «*angustia positiva y activa*». Y uno de los aspectos más intolerables de un interludio tal es la incapacidad para dormir. Últimamente era mi costumbre, como la de mucha gente, tomarme una siesta relajante en las tardes, pero la alteración de los patrones normales de sueño es un rasgo notoriamente devastador de la depresión; a la perjudicial falta de sueño con la que yo había sido afligido cada noche se añadió la afrenta del insomnio aquella tarde, diminuta en comparación, pero aún más terrible porque golpeaba durante las horas de la más intensa miseria. Estaba claro que nunca se me iba a conceder ni unos pocos minutos de alivio de mi agotamiento *full-time*. Recuerdo claramente que vislumbraba, cuando yacía allí mientras Rose estaba sentada cerca leyendo, que mis tardes y noches empeoraban significativamente, y que este episodio era el peor hasta la fecha.

Pero de alguna manera me las arreglé para volver a componerme para la cena con —¿quién más?— Françoise Gallimard, co-víctima, junto con Simone Del Duca del desagradable contratiempo del mediodía.

La noche era tempestuosa y cruda, con un viento frío y húmedo que soplabá por las avenidas. Cuando Rose y yo nos encontramos con Françoise, su hijo y un amigo en La Lorraine, una rutilante *brasserie* no lejos de L'Etoile, la lluvia estaba descendiendo de los cielos en torrentes. Alguien en el grupo, sintiendo mi estado de ánimo, se disculpó por la mala noche, pero recuerdo haber pensado que incluso si hubiera sido una de esas tardes cálidamente perfumadas y apasionadas por las

cuales París es celebrada yo habría respondido como el zombi en me había convertido. El tiempo de la depresión es desarticulado, su luz como una baja de tensión.

Y como un zombi a mitad de la cena, perdí el cheque de del Duca del premio de 25.000 dólares. Después de haberlo metido en el bolsillo interior de mi chaqueta, deslicé mi mano a ese lugar cruzando los brazos y me di cuenta que ya no estaba. ¿Tenía yo la *intención* de perder el dinero? Recientemente había estado profundamente preocupado de que no era merecedor del premio. Yo creo en la realidad de los accidentes que inconscientemente cometemos sobre nosotros mismos, y así cuán fácil era que esta pérdida no fuera una pérdida, sino una forma de repudio, la rama de ese odio a sí mismo (el principal distintivo de la depresión) por el cual yo estaba convencido de que no podía ser digno del premio, que yo no era, de hecho, digno de ningún reconocimiento recibido en los últimos años. Cualquiera que fuese la razón de su desaparición, el cheque no estaba, y su pérdida encajaba bien con los otros fracasos de la cena: mi falta de apetito ante el gran *plateau de fruits de mer* colocado frente a mí, el fracaso de la risa, incluso forzada y, por fin, el fracaso casi total del habla. En este punto el feroz dolor interior provocaba una inmensa distracción que impedía que articulara mis palabras más allá de un murmullo ronco; me sentí a mi mismo como girando con los ojos extraviados, monosilábico, y también me di cuenta de que mis amigos franceses se ponían inquietos al tanto de mi predicamento. Ya era una escena de una mala opereta: todos cerca del piso, buscando el dinero desaparecido. Justo cuando hice señas de que era hora de irse, el hijo de Françoise descubrió el cheque, que se había deslizado de alguna manera fuera de mi bolsillo y había revoloteado bajo una mesa contigua, y salimos a la noche lluviosa. Entonces, mientras estaba subiendo en el coche, pensé en Albert Camus y Romain Gary.

II

Cuando yo era un joven escritor hubo una etapa en la que Camus, casi más que cualquier otra figura literaria contemporánea, estableció radicalmente el tono de mi propia visión de la vida y de la historia. Leí su novela *The Stranger* algo más tarde de lo que debería —yo estaba en mis treinta y pocos años. Después de terminar eso recibí la punzada del reconocimiento que sale de la lectura de la obra de un escritor que ha casado la pasión moral a un estilo de gran belleza y cuya visión sin pestañear es capaz de asustar al alma hasta su médula. La soledad cósmica de Meursault, el héroe de la novela, no me dejaba cuando me puse a escribir *Las confesiones de Nat Turner*; me sentí impulsado a utilizar el recurso de Camus de plantear el flujo de la historia desde el punto de vista de un narrador aislado en su celda, durante las horas previas a su ejecución. Para mí había una conexión espiritual entre la soledad helada de Meursault y la difícil situación de Nat Turner —su rebelde predecesor en la historia por cien años— igualmente condenado y abandonado por el hombre y por Dios. El ensayo de Camus *Reflexiones sobre la guillotina* es un documento prácticamente único, cargado de lógica terrible e intensa; es difícil concebir del partidario más vengativo de la pena de muerte, que mantenga la misma actitud después de la exposición a las verdades mordaces expresadas con tanta afición y precisión. Sé que mi pensamiento quedó alterado para siempre por ese trabajo, no sólo me dio vuelta por completo, convenciéndome de la barbarie esencial de la pena capital, sino estableciendo sustanciales reclamos sobre mi conciencia respecto de las cuestiones de responsabilidad en general. Camus fue un gran limpiador de mi intelecto, librándome de innumerables ideas vagas, y a través de algunas, del pesimismo más inquietante que jamás hubiera encontrado; impulsándome de nuevo hacia la enigmática promesa de la vida.

La decepción que sentí por no haber conocido a Camus

personalmente se combinó con un encuentro fallido que estuvo muy cerca. Yo había planeado volver a verlo en 1960, cuando viajaba a Francia y el escritor Romain Gary me informó en una carta, que iba a organizar una cena en París, donde me encontraría con Camus.

El enormemente talentoso Gary, a quien yo conocía hacía poco y que más tarde se convirtió en un querido amigo, me había informado de que Camus, a quien veía con frecuencia, había leído mi *Un Lit de Tenebres* y le había gustado; yo estaba, por supuesto, enormemente halagado y pensé que un encuentro sería un espléndido acontecimiento. Pero antes de llegar a Francia recibí la noticia terrible: Camus había muerto en un accidente de automóvil, cruelmente a la temprana edad de cuarenta y seis años. Casi nunca he sentido tan intensamente la pérdida de alguien a quien yo no conociera. Reflexioné sobre su muerte intensamente. Aunque Camus no conducía, supuestamente conocía al conductor, que era el hijo de su editor, un demonio de la velocidad; así, había un elemento de imprudencia en el accidente que daba visos de casi suicidio, por lo menos de un coqueteo con la muerte, y era inevitable hacer conjeturas referentes al hecho que devolvían al tema del suicidio en la obra del escritor. Uno de los pronunciamientos intelectuales más famosos del siglo llega al principio de *El mito de Sísifo*:

«No hay más que un problema filosófico realmente serio, y ese es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida llega a ser la respuesta a la pregunta fundamental de la filosofía».

Luego de leer esto por primera vez quedé perplejo y continué así a través de gran parte del ensayo, ya que a pesar de la persuasiva lógica y elocuencia de la obra, había mucho que se me escapaba, y siempre volvía a enfrentarme vanamente con la hipótesis inicial, incapaz, en el primer lugar, de lidiar con la premisa de que toda persona debería meditar sobre el deseo de

quitarse la vida.

A una novela corta posterior, *The Fall*, la admiré con reservas; la culpa y auto-condena del abogado narrador, que alarga sombríamente su monólogo en un bar de Amsterdam, parecían un toque estrepitoso y excesivo, pero en el momento de mi lectura fui incapaz de percibir que el abogado se estaba comportando de forma muy similar a un hombre en medio de la depresión clínica. Tal fue mi inocencia respecto a la existencia de esta enfermedad en mí.

Camus, me dijo Romain, de vez en cuando insinuó su propio profundo desaliento y había hablado de suicidio. A veces hablaba en broma, pero la broma tenía la calidad del vino agrio, alterando a Romain. Sin embargo, al parecer nunca intentó suicidarse y así tal vez no fuera una coincidencia que, a pesar de su permanente tono melancólico, esté en el centro de *El mito de Sísifo* un sentimiento de triunfo de la vida sobre la muerte con su mensaje severo; en ausencia de esperanza todavía tenemos que luchar para sobrevivir, y así lo hacemos aunque apenas. Fue sólo después de algunos años que me pareció creíble que las afirmaciones de Camus sobre el suicidio, y su preocupación general por el tema, podrían haber surgido, tan fuertemente por lo menos, tanto de algún persistente trastorno del estado de ánimo como de sus preocupaciones con la ética y la epistemología. Gary volvió a discutir en detalle sus supuestos acerca de la depresión de Camus durante agosto de 1978, cuando yo le había prestado mi casa en Connecticut, y fui desde mi casa de verano en Martha's Vineyard a hacerle una visita de fin de semana. Mientras hablábamos sentí que algunas de las suposiciones de Romain acerca de la gravedad de la desesperación recurrente de Camus, se reafirmaban más por el hecho de que él, también, había comenzado a sufrir de depresión, según admitió libremente. No era incapacitante, insistió, y él tenía todo bajo control, pero sentía de vez en cuando este estado de ánimo plomizo y venenoso, tan incongruente en medio del exuberante verano de Nueva

Inglaterra. Romain, un judío ruso nacido en Lituania, siempre parecía poseído de esa melancolía de los europeos del Este, así que era difícil reconocer la diferencia. Sin embargo, él estaba sufriendo. Dijo que era capaz de percibir un destello del desesperado estado de la mente que Camus le había descrito.

La situación de Gary fue apenas aliviada por la presencia de Jean Seberg, su esposa nacida en Iowa, actriz, de quien se había divorciado y, yo creía, también distanciado.

Me enteré de que ella estaba allí porque su hijo, Diego, se encontraba en un campamento de tenis cerca. Dado su presunto distanciamiento me sorprendió verla junto a Romain, y quedé muy sorprendido también, o mejor dicho, golpeado y entristecido por su apariencia: toda su una vez frágil y luminosa belleza rubia había desaparecido en una máscara hinchada. Que se movía como una sonámbula es decir poco, tenía la mirada vacía de alguien sedado (o drogado, o ambos) casi hasta el punto de la catalepsia. Comprendí cuán devotos todavía eran entre sí, y me conmovió su solicitud, a la vez tierna y paternal. Romain me dijo que Jean estaba siendo tratada por la enfermedad que lo aquejaba a él, y mencionó algo acerca de los medicamentos antidepresivos, pero nada de esto expresado con mucha fuerza tampoco significaba mucho. Esta memoria de mi indiferencia relativa es importante porque demuestra poderosamente la incapacidad de los extraños de captar la esencia de la enfermedad. La depresión de Camus y ahora de Romain Gary —y ciertamente la de Jean— eran dolencias abstractas para mí, a pesar de mi simpatía, y yo no tenía la menor idea de sus verdaderos contornos o de la naturaleza del dolor que tantas víctimas experimentan mientras la mente continúa colapsándose.

En París esa noche de octubre supe que yo también estaba en el proceso de colapso. Y en el camino hacia el hotel en el coche tuve una revelación clara. Una interrupción de los ciclos circadianos —ritmos metabólicos y glandulares que son fundamentales para nuestra vida diaria— parece estar

implicada en muchos, si no en la mayoría, de los casos de depresión; esta es la razón por la que ocurre el brutal insomnio tan a menudo, y es más probable que sea así porque el patrón diario de estrés exhibe períodos alternados de intensidad y alivio bastante predecibles.

Mi alivio de la noche —una tregua incompleta pero notable, al igual que el cambio de una lluvia torrencial a una ducha suave— se produjo en las primeras horas después de la cena y antes de la medianoche, cuando el malestar disminuyó un poco y mi mente se puso lo suficientemente lúcida como para enfocarme en asuntos que excedieran la conmoción inmediata que convulsionaba mi sistema. Naturalmente esperaba la llegada de ese periodo, porque a veces me sentía cerca de estar razonablemente sano, y esa noche en el coche notaba los indicios de un retorno a la lucidez, junto con la capacidad de tener pensamientos racionales. Habiendo sido capaz de evocar a Camus y Romain Gary, sin embargo, me di cuenta de que mis continuos pensamientos no eran muy consoladores.

El recuerdo de Jean Seberg se apoderó de mí con tristeza.

A poco más de un año después de nuestro encuentro en Connecticut tomó una sobredosis de pastillas y fue encontrada muerta en un coche estacionado en una calle sin salida de una avenida de París, donde su cuerpo había permanecido durante muchos días. Al año siguiente me senté con Romain en la *Brasserie Lipp* durante un largo almuerzo; me contó que, dejando de lado sus dificultades, su pérdida de Jean había profundizado tanto su depresión que de vez en cuando se sentía desahuciado. Pero incluso entonces yo era incapaz de comprender la naturaleza de su angustia. Recordaba que le temblaban las manos y, aunque apenas podía decirse jubilado — se encontraba en la mitad de los sesenta — su voz tenía el sonido jadeante de los de edad muy avanzada, que ahora me doy cuenta era, o podía ser, la voz de la depresión; en el vórtice de mi dolor más severo yo mismo había comenzado a desarrollar esa voz

anciana. Fue la última vez que vi a Romain.

Claude Gallimard, el padre de Françoise, me había contado como, en 1980, sólo unas horas después de otro almuerzo donde la charla entre dos viejos amigos había sido tranquila y casual incluso alegre y, ciertamente, cualquier cosa menos sombría, Romain Gary — dos veces ganador, del Premio Goncourt (uno de esos premios bajo seudónimo, el resultado de su padecimiento engañó alegremente a los críticos), héroe de la República, el destinatario valeroso de la *Croix de Guerre*, diplomático, *bon vivant*, mujeriego por excelencia, regresó a su apartamento en la Rue du Bac y puso una bala en su cerebro.

Fue en algún momento durante el curso de estas reflexiones que el cartel del hotel Washington pasó por mi visión, trayendo de vuelta los recuerdos de mi llegada hace mucho tiempo a la ciudad, junto con la comprensión feroz y repentina de que no volvería a ver París nuevamente. Esta certeza me sorprendió y me llenó de un nuevo temor, pues aunque los pensamientos de muerte habían sido comunes durante mi estadía, soplando a través de mi mente como ráfagas heladas, eran las figuras amorfas de la fatalidad que supongo son las soñadas por personas en las garras de cualquier aflicción severa.

La diferencia ahora radicaba en la comprensión segura de que mañana, cuando el dolor descendiera una vez más, o la mañana siguiente — sin duda en algún futuro no muy lejano — me vería obligado a juzgar que la vida no valía la pena vivirse y por lo tanto la respuesta, para mí al menos, a la cuestión fundamental de la filosofía.

III

Para muchos de quienes conocían a Abbie Hoffman aunque fuera lejanamente, como yo, su muerte en la primavera de 1989 fue un acontecimiento doloroso. Justo después de los cincuenta años, era aún demasiado joven y, aparentemente, demasiado vital para tal final; un sentimiento de disgusto y espanto asiste a la noticia del suicidio de cualquiera, y la muerte de Abbie me parecía especialmente cruel. Lo había conocido durante los días y noches salvajes de la Convención Demócrata de 1968 en Chicago, donde había ido a escribir un artículo para *The New York Review of Books*, y más tarde fui uno de los que testificaron a favor de él y de sus compañeros acusados en el juicio, también en Chicago, en 1970. En medio de las locuras piadosas y perversiones morbosas de la vida estadounidense, su estilo grotesco era estimulante, y era difícil no admirar el desorden infernal y el brío, el individualismo anárquico. Me gustaría haber visto más de él en los últimos años; su repentina muerte me dejó un vacío en particular, como los suicidios suelen hacer a todo el mundo. Pero al evento se le dio una nueva dimensión de patetismo, por lo que hay que empezar a considerar como una reacción previsible de muchos: el rechazo, la negativa a aceptar el hecho del suicidio en sí mismo, como si el acto voluntario —a diferencia de un accidente o muerte por causas naturales— se tiñera de una condición delictiva que de alguna manera disminuye al hombre y su carácter.

El hermano de Abbie apareció en la televisión, devastado por el duelo y angustiado; uno no podía dejar de sentir compasión cuando trató de desviar la idea del suicidio, insistiendo en que Abbie, después de todo, siempre había sido descuidado con pastillas y nunca habría dejado a su familia despojada. Sin embargo, el médico forense confirmó que Hoffman había tomado el equivalente de 150 comprimidos de fenobarbital. Es muy natural que las personas más cercanas a las víctimas de suicidio con tanta frecuencia y febrilmente se

apresuran a negar la verdad; el sentido de implicación, de culpa personal —la idea de que se podría haber evitado el acto si se hubieran tomado ciertas precauciones, o se hubiera comportado de alguna manera diferente— es tal vez inevitable. Aun así, la víctima —si se ha matado realmente a sí misma o intentado hacerlo, o simplemente expresado amenazas— es a menudo, a través de la negación por parte de otros, injustamente hecha aparecer como un malhechor.

Un caso similar es el de Randall Jarrell —uno de los finos poetas y críticos de su generación— que una noche en 1965, cerca de Chapel Hill, Carolina del Norte, fue atropellado por un coche y murió. La presencia de Jarrell en ese tramo particular de carretera, a una hora extraña de la noche, fue desconcertante, y dado que había indicios de que había dejado deliberadamente que el coche lo golpeará, la conclusión inicial fue que su muerte fue un suicidio.

Newsweek, entre otras publicaciones, dijo lo mismo, pero la viuda de Jarrell protestó en una carta a la revista; hubo un clamor de muchos de sus amigos y partidarios, y el juez dictaminó finalmente la muerte como accidental. Jarrell había estado sufriendo de depresión extrema y había sido hospitalizado; sólo unos pocos meses antes de su desventura en la carretera y en el hospital, se había cortado las venas.

Cualquiera que esté familiarizado con algunos de los contornos ásperos de la vida de Jarrell —incluyendo sus violentas fluctuaciones del estado de ánimo y sus accesos de negro desaliento—, y que, además, ha adquirido un conocimiento básico de las señales de peligro de la depresión, podría cuestionar seriamente el veredicto del juez. Pero el estigma de la muerte autoinfligida es para algunas personas una mancha odiosa que exige el borrado a toda costa. (Más de dos décadas después de su muerte, en la edición de verano de 1986 de *The American Scholar*, un antiguo estudiante de Jarrell, hizo una revisión de una colección de cartas del poeta, y escribió más que una revisión literaria o biográfica, haciendo esfuerzos

para exorcizar el fantasma vil del suicidio).

Randall Jarrell casi seguro que se suicidó. No lo hizo porque fuera un cobarde, ni por ninguna debilidad moral, sino porque él estaba aquejado de una depresión que fue tan devastadora que ya no podía soportar el dolor de la misma.

Esta falta de conciencia general de lo que la depresión es realmente se hizo evidente recientemente en la cuestión de Primo Levi, escritor italiano notable y sobreviviente de Auschwitz que, a la edad de sesenta y siete años, se lanzó por una escalera en Turín en 1987. Desde mi propia implicación con la enfermedad, yo había estado más que ordinariamente interesado en la muerte de Levi, y así, a finales de 1988, cuando leí un artículo en *The New York Times* acerca de un simposio sobre el escritor y su obra que tuvo lugar en la Universidad de Nueva York, estuve fascinado, pero, finalmente, horrorizado. Porque, de acuerdo con el artículo, muchos de los participantes, escritores y eruditos mundanos, parecían desconcertados por el suicidio de Levi, desconcertados y decepcionados.

Era como si este hombre a quien todos habían admirado tanto, y que había sufrido mucho a manos de los nazis —un hombre de resistencia ejemplar y coraje— hubiera demostrado con su suicidio una debilidad, un desmoronamiento de carácter que eran reacios a aceptar. De cara a una terrible absoluta autodestrucción su reacción fue impotencia y (el lector no podía evitarlo) un toque de vergüenza.

Mi molestia sobre todo esto era tan intensa que me animé a escribir un pequeño fragmento en la página de opinión del *Times*. El argumento que expuse era bastante sencillo: el dolor de la depresión severa es bastante inimaginable para aquellos que no la han sufrido, y mata en muchos casos debido a que la angustia ya no se puede soportar. La prevención de muchos suicidios continuará siendo obstaculizada hasta que haya una toma de conciencia general sobre la naturaleza de este dolor. A través del proceso sanador del tiempo —y de la intervención médica u hospitalización en muchos casos— la mayoría de la

gente sobrevive a la depresión, que puede ser su única bendición; pero a la legión trágica que se ven obligados a aniquilarse a sí mismos no debe haber más reproche que el que se hace a las víctimas de cáncer terminal.

Había expresado mis pensamientos en este artículo del *Times* un poco apresurada y espontáneamente y la respuesta fue igualmente espontánea y enorme. No contaba, especulé, ninguna especial originalidad ni audacia de mi parte para hablar francamente sobre el suicidio y el impulso hacia él, pero al parecer había subestimado el número de personas para quienes el tema era tabú, una cuestión de secreto y vergüenza. La reacción abrumadora me hizo sentir que sin querer había ayudado a abrir un armario del que muchas almas estaban ansiosas por salir y proclamar que ellas también habían experimentado los sentimientos que había descrito. Es la única vez en mi vida que he sentido que valió la pena haber invadido mi propia privacidad, y hacerla pública. Y pensé que, dado tal impulso, y con mi experiencia en París como ejemplo detallado de lo que ocurre durante la depresión, sería útil tratar de registrar algunas de mis propias experiencias con la enfermedad, y en el proceso tal vez establecer un marco de referencia a partir del cual pudieran extraerse uno o más datos valiosos. Tal información, debe destacarse, aún se basa en los hechos que le ocurrieron a un solo hombre. Al establecer estas reflexiones no tengo la intención de presentar mi terrible experiencia como una descripción de lo que ocurre, o puede ocurrir, a los demás. Las causas, síntomas y tratamiento de la depresión son demasiado complejas para extraer conclusiones de la experiencia de un solo individuo.

Como toda enfermedad la depresión manifiesta ciertas características invariables, pero también admite muchas particularidades; he quedado sorprendido por algunos de los fenómenos —no informados por otros pacientes— que se han forjado en medio de los giros del laberinto de mi mente.

La depresión afecta a millones de personas directamente,

y millones más que son parientes o amigos de las víctimas. Se ha estimado que hasta uno de cada diez estadounidenses sufren la enfermedad. Tan asertivamente democrática como un poster de Norman Rockwell, golpea indiscriminadamente a todas las edades, razas, credos y clases, aunque las mujeres tienen un riesgo considerablemente mayor que los hombres. La lista de ocupaciones (modistas, capitanes de barco, chefs de sushi, miembros del gabinete) de sus pacientes es demasiado larga y tediosa para ponerla aquí; basta con decir que muy pocas personas escapan de ser víctimas potenciales de la enfermedad, al menos en sus formas más leves.

Aún en casos moderados de depresión, se ha demostrado en forma bastante contundente que los tipos artísticos (especialmente poetas) son particularmente vulnerables a la enfermedad —que, en sus manifestaciones clínicas más graves terminan hasta un veinte por ciento de sus víctimas en suicidio. Sólo unos pocos de estos artistas caídos, todos modernos, constituyen una triste pero contundente lista: Hart Crane, Vincent van Gogh, Virginia Woolf, Arshile Gorky, Cesare Pavese, Romain Gary, Vachel Lindsay, Sylvia Plath, Henry de Montherlant, Mark Rothko, John Berryman, Jack London, Ernest Hemingway, William Inge, Diane Arbus, Tadeusz Borowski, Paul Celan, Anne Sexton, Sergei Esenin, Vladimir Maya-kovsky — la lista sigue. (El poeta ruso Maya-kovsky fue muy crítico del suicidio de su contemporáneo Esenin un par de años antes, que sirva como una advertencia para todos los que emiten juicios sobre la autodestrucción.) Cuando uno piensa en estos espléndidamente creativos hombres y mujeres condenados, uno se ve llevado a contemplar sus infancias, en las que, según el leal saber y entender de cualquier persona, las semillas de la enfermedad tienen raíces fuertes; ¿podría alguno de ellos haber tenido una pista, entonces, de la capacidad de perecer de la psique en su exquisita fragilidad? ¿Y por qué se destruyeron, mientras que otros —golpeados de manera similar — continúan luchando?

IV

Cuando fui consciente por primera vez de que yo había estado postrado por la enfermedad, sentí la necesidad, entre otras cosas, de expresar una fuerte protesta en contra de la palabra *depresión*. La depresión, la mayoría de la gente sabe, se solía llamar *melancolía*, una palabra que aparece ya en el año 1303 y se la encuentra más de una vez en Chaucer, quien en su uso parecía ser consciente de sus matices patológicos.

Melancolia todavía parece ser una palabra mucho más apta y evocadora de las formas más negras de la enfermedad, pero fue usurpada por un sustantivo con una tonalidad sosa y carente de toda presencia magistral, utilizada indistintamente para describir una declinación económica o un bache en la tierra, una palabra verdaderamente floja para una enfermedad tan grave. Puede ser que los científicos sean responsables de su difusión en los tiempos modernos. Un miembro de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins justamente venerado —el psiquiatra de origen suizo Adolf Meyer— tenía un pésimo oído para los ritmos más finos del Inglés y por lo tanto no tenía conocimiento del daño semántico que había infligido al ofrecer *depresión* como un nombre descriptivo para una enfermedad tan terrible y furiosa. Sin embargo, por más de setenta y cinco años, la palabra se ha deslizado inofensivamente a través del lenguaje como una babosa, dejando pocos rastros de su maldad intrínseca y prevención, por su propia insipidez, una impasibilidad general ante la horrible intensidad de la enfermedad cuando se sale de control.

Como alguien que ha sufrido de la enfermedad *in extremis* y todavía regresado para contarla, me gustaría abogar por una designación realmente arrebatadora. *Brainstorm*, por ejemplo, ha sido lamentablemente utilizada para describir, algo jocosamente, la inspiración intelectual. Pero se necesita algo en este sentido. Expresar que el trastorno del estado de ánimo de una persona se ha convertido en una tormenta —un verdadero

huracán soplando en el cerebro, que es de hecho a lo que una depresión clínica se parece como ninguna otra cosa. Aún el lego desinformado podría mostrar compasión en lugar de la reacción estándar que la depresión evoca, algo parecido a «¿Y qué?» o «*Vas a salir de ella*» o «*Todos tenemos días malos*». La frase *ataque de nervios* parece estar cayendo en desuso, por cierto merecidamente, debido a su insinuación de una vaga debilidad de carácter, pero todavía parece destinada a encajar con la *depresión* hasta que se cree un sustantivo mejor y más fuerte.

La depresión que me absorbió no era del tipo maniaco — aquella acompañada de picos de euforia — que muy probablemente pudo presentarse antes en mi vida. Yo tenía sesenta cuando la enfermedad me golpeó por primera vez, en la forma *unipolar*, que conduce directamente hacia abajo. Nunca voy a entender lo que *causó* mi depresión, como nadie va a entenderse a sí mismo. Poder hacerlo probablemente resulte imposible, por lo complejo que son los factores entremezclados de la química anormal, el comportamiento y la genética. Claramente, están involucrados múltiples componentes, tal vez tres o cuatro, muy probablemente más, en permutaciones insondables.

Es por eso que la mayor falacia en el suicidio radica en la creencia de que hay una sola respuesta inmediata — o tal vez pocas respuestas combinadas — de por qué se dio ese paso.

La inevitable pregunta «¿*Por qué él o ella lo hicieron?*» por lo general conduce a especulaciones incorrectas, en su mayor parte falacias en sí mismas. Varias razones fueron rápidamente declaradas por la muerte de Abbie Hoffman: su reacción ante un accidente automovilístico que había sufrido, el fracaso de su libro más reciente, la grave enfermedad de su madre. Con Randall Jarrell era una carrera en declive cruelmente señalada por una viciosa reseña de su libro y la consecuente angustia. Primo Levi, se rumoreaba, estaba agobiado por el cuidado de su madre paralítica, que era más oneroso para su espíritu, que su experiencia en Auschwitz. Cualquiera de estos factores pudo

alojarse como una espina en los cuerpos de los tres hombres, y haber sido un tormento. Tales agravios pueden ser cruciales y no deben ser ignorados.

Pero la mayoría de la gente soporta el equivalente de las lesiones en silencio, carreras declinantes, desagradables reseñas de libros, enfermedades familiares. Una gran mayoría de los sobrevivientes de Auschwitz lo ha sobrellevado bastante bien. Sangrados y cabizbajos por los desmanes de la vida, la mayoría de los seres humanos aún se tambalean por el camino, pero lejos de la depresión real. Para descubrir por qué algunas personas se hunden en la espiral descendente de la depresión, hay que buscar más allá de la crisis manifiesta —y aún así no llegará más allá de sabias conjeturas.

La tormenta que me arrastró a un hospital en diciembre comenzó como una nube del tamaño de una copa de vino en el mes de junio anterior. Y la nube —la crisis manifiesta— involucraba el alcohol, una sustancia de la que había estado abusando durante cuarenta años. Como un gran número de escritores norteamericanos, cuya letal adicción al alcohol se ha vuelto tan legendaria como para proporcionar por sí misma una corriente de estudios y libros, he usado el alcohol como el conducto mágico para la fantasía y la euforia, y para mejorar la imaginación. No hay necesidad de lamentarse o disculparse por mi uso de este reconfortante, a menudo sublime agente, que ha contribuido en gran medida a lo que escribo; aunque nunca escribí una línea, mientras estaba bajo su influencia, lo usé —a menudo en combinación con la música— como un medio para dejar que mi mente concibiera visiones a las cuales el inalterado y sobrio cerebro no tiene acceso. El alcohol fue un socio principal inestimable de mi intelecto, además de ser un amigo cuya ayuda busqué a diario —lo busqué también, ahora lo veo— como un medio para calmar la ansiedad y el temor incipiente que había escondido durante tanto tiempo en algún lugar en las mazmorras de mi espíritu.

El problema fue que a principios de ese verano en

particular, fui traicionado. Se me ocurrió de repente, casi de la noche a la mañana: ya no podía beber. Era como si mi cuerpo se hubiera levantado en señal de protesta, junto con mi mente, y hubiera conspirado para rechazar este baño de humor diario que había acogido durante tanto tiempo y, ¿quién sabe? tal vez incluso vuelva a necesitar. Muchos bebedores han experimentado esta intolerancia, a medida que envejecen. Sospecho que la crisis fue al menos en parte, metabólica —el hígado se rebeló, como para decir: «*No más, no más*», pero en todo caso, descubrí que el alcohol en cantidades minúsculas, incluso un trago de vino, me causaba náuseas, un mareo desesperado y desagradable, una sensación de hundimiento y básicamente una marcada repulsión. El amigo reconfortante me había dejado, no poco a poco y de mala gana, como un verdadero amigo puede hacerlo, sino con una patada, dejándome abandonado, y sin duda desarmado.

Y no fue por voluntad ni por elección que me hubiera convertido en un abstemio; la situación era desconcertante para mí, pero también traumática, y así pongo fecha al inicio de mi estado de ánimo depresivo desde el comienzo de esta privación. Lógicamente, uno debiera estar encantado de que el cuerpo haya desestimado tan sumariamente una sustancia que fue minando su salud; era como si mi sistema hubiera generado una forma de *Antabuse*², que debería haberme permitido seguir feliz mi camino, satisfecho de que un truco de la naturaleza me hubiera alejado de una dependencia perjudicial. Pero, en cambio, empecé a experimentar un malestar vagamente inquietante, una sensación de haber pasado algo disparatado en el universo doméstico que habité tanto tiempo, tan cómodamente.

Mientras que la depresión no es en absoluto desconocida cuando la gente deja de beber, por lo general es en un grado que no resulta amenazante. Pero hay que tener en cuenta cuán

² Medicamento usado en el tratamiento de la adicción al alcohol (NdT)

particulares pueden ser las caras de la depresión.

No era realmente alarmante al principio, ya que el cambio fue sutil, pero me di cuenta de que mi entorno adquiriría un tono diferente en ciertos momentos: la oscuridad de la noche parecía más sombría, mis mañanas eran menos animadas, las caminatas en el bosque se hicieron menos apasionantes, y había un momento durante mis horas de trabajo en la tarde, cuando una especie de pánico y la ansiedad se apoderaba de mí, sólo por unos minutos, acompañado de un mareo visceral; tales ataques, eran al menos ligeramente alarmantes, después de todo. A medida que escribo estos recuerdos, me doy cuenta de que debería haber estado claro para mí que yo ya estaba en las garras del inicio de un trastorno del estado de ánimo, pero era ignorante de tal condición en ese momento.

Cuando reflexioné sobre esta curiosa alteración de mi conciencia —y yo estaba demasiado confundido de tiempo en tiempo para hacerlo— supuse que todo tenía que ver de alguna manera con mi suspensión forzosa de alcohol. Y, por supuesto, en cierta medida, esto era cierto. Ahora estoy convencido de que el alcohol jugó un truco perverso en mí cuando nos despedimos; aunque, como todos deben saber, es un depresivo mayor, realmente nunca me había deprimido durante mi carrera alcohólica, actuando en cambio como un escudo contra la ansiedad. De repente desapareció; el gran aliado que durante tanto tiempo había mantenido mis demonios a raya ya no estaba allí para evitar que esos demonios comenzaran a pulular a través del subconsciente, y yo estaba emocionalmente desnudo, vulnerable como nunca lo había estado antes.

Sin duda, la depresión se había mantenido cerca de mí durante años, esperando para abalanzarse. Ahora estaba en la primera etapa —premonitoria, como el destello de un relámpago apenas percibido— de la negra tempestad de la depresión.

Yo estaba en Martha's Vineyard, donde he pasado una buena parte de cada año desde la década de 1960, durante ese

verano excepcionalmente bello. Pero había comenzado a responder con indiferencia a los placeres de la isla. Sentí una especie de adormecimiento, una enervación, pero sobre todo una extraña fragilidad, como si mi cuerpo se hubiera hecho en realidad frágil, hipersensible y de alguna manera desarticulado y torpe, carente de coordinación normal. Y pronto me encontraba en medio de una hipocondría generalizada. Nada se sentía del todo bien con mi yo corpóreo; tenía espasmos y dolores, a veces intermitentes, a menudo aparentemente constantes, que parecían presagiar todo tipo de enfermedades graves.

(Teniendo en cuenta estas señales, se puede comprender cómo, ya en el siglo XVII —en las notas de los médicos contemporáneos, y en las percepciones de John Dryden y otros— se hace una conexión entre la melancolía y la hipocondría, las palabras eran a menudo intercambiables, y continuaron así hasta el siglo XIX por autores tan diversos como Sir Walter Scott y las hermanas Brontë, que también vinculaban la melancolía a una preocupación por los males corporales). Es fácil ver cómo esta condición es parte del aparato de defensa de la psique: reticente a aceptar su propio deterioro, la mente le anuncia a la conciencia que mora en nosotros, que es el cuerpo con sus defectos corregibles quizás —no la mente preciosa e insustituible— que se está tornando caótico.

En mi caso, el efecto general era inmensamente perturbador, aumentando la ansiedad que ya nunca se ausentaba de mis horas de vigilia y alimentando aún otro patrón de comportamiento extraño —una inquietud nerviosa que me mantenía en movimiento, para perplejidad de mis familiares y amigos. Una vez, a finales del verano, en un viaje en avión a Nueva York, yo cometí el error imprudente de bajarme un whisky con soda —mi primer alcohol en un mes— que me envió rápidamente en picada, causándome tal horrible sensación de enfermedad y fatalidad que al día siguiente me precipité a un internista de Manhattan, que inauguró una larga

serie de análisis. Normalmente habría quedado satisfecho, de hecho, eufórico, cuando, después de tres semanas de evaluación de alta y muy costosa tecnología, el médico me declaró totalmente en forma; y yo estuve feliz, por un día o dos, hasta que comenzó una vez más la rítmica erosión diaria de mi estado de ánimo-ansiedad, agitación y miedo sin causa.

Ahora me había mudado de vuelta a mi casa en Connecticut. Era octubre, y uno de los rasgos inolvidables de esta etapa de mi enfermedad fue la forma que mi vieja casa de campo, mi querida casa durante treinta años, adquirió para mí en ese momento, cuando mi espíritu estaba hundido en su punto más bajo, una casi palpable calidad de abominable. La atenuada luz del atardecer — similar a la famosa "inclinación de la luz" de Emily Dickinson, que le habló de la muerte, de la fría extinción— no tenía nada de su familiar belleza otoñal, pero sí me atrapó en una oscuridad sofocante. Me preguntaba cómo este lugar amable, lleno de esos recuerdos de (de nuevo en sus palabras) «*chicos y chicas*», de «*risas, aptitud y suspiros, y faldas y rizos*», podría casi perceptiblemente parecer tan hostil y amenazadora.

Físicamente, no estaba solo. Como siempre, Rose estaba presente y escuchó mis quejas con paciencia incansable.

Pero sentí una inmensa y dolorosa soledad. Yo ya no podía concentrarme en esas horas de la tarde, que durante años habían sido mi tiempo de trabajo, y el acto de la escritura misma, haciéndose cada vez más difícil y agotadora, se estancó, y finalmente cesó.

También fueron abalanzándose horribles ataques de ansiedad.

Un día brillante, en un paseo por el bosque con mi perro, oí una bandada de gansos de Canadá, graznando por encima de los árboles con el follaje incandescente; ordinariamente una vista y sonido que me habría regocijado, el vuelo de los pájaros me hizo detenerme, cautivado por el miedo, y me quedé varado allí, impotente, tembloroso, consciente por primera vez de que

no había sido golpeado por meros dolores de la vejez sino por una enfermedad grave, cuyo nombre y realidad finalmente fui capaz de reconocer. De vuelta a casa, no pude librar mi mente de la línea de Baudelaire, desenterrada de un pasado lejano, que desde hacía varios días había estado deslizándose en torno al borde de mi conciencia: «*He sentido el viento del ala de la locura*».

Nuestra quizás comprensible necesidad moderna de suavizar tantas de las aflicciones que estamos heredando, nos ha llevado a desterrar las duras palabras antiguas: *manicomio, asilo, locura, melancolía, lunático*. Pero nunca puede dudarse que la depresión, en su forma extrema, es una locura. La locura resulta de un proceso bioquímico aberrante. Se ha establecido con certeza razonable (después de una fuerte resistencia de muchos psiquiatras, y no hace tanto tiempo) que tal locura es inducida químicamente entre los neurotransmisores del cerebro, probablemente como resultado de la tensión sistémica, que por razones desconocidas provoca un agotamiento de la *norepinefrina* y la *serotonina* y el aumento de una hormona, *cortisol*.

Con toda esta conmoción en los tejidos del cerebro, el remojón alternativo y la privación, no es de extrañar que la mente comience a sentirse agraviada, herida, y los enturbiados procesos de pensamiento registren la aflicción de un órgano en convulsión. A veces, aunque no muy a menudo, tal mente perturbada se volverá a pensamientos violentos en relación con los demás.

Pero con sus mentes vueltas agónicamente hacia adentro, las personas con depresión suelen ser peligrosas sólo para sí mismas. La locura de la depresión es, en términos generales, la antítesis de la violencia.

Es una tormenta de hecho, pero una tormenta de oscuridad. Pronto son evidentes las respuestas ralentizadas, cerca de la parálisis, la energía psíquica reducida hasta cerca de cero. En última instancia, el cuerpo se ve afectado y se siente debilitado, drenado.

Ese otoño, a medida que el trastorno tomaba plena posesión de mi sistema, empecé a concebir que mi mente era como una de esas antiguas centrales telefónicas que gradualmente comenzaba a inundarse, uno a uno, los circuitos normales dejaban de operar, haciendo que algunas de las funciones del cuerpo y casi todas las del instinto y el intelecto se desconecten lentamente.

Hay una lista de verificación bien conocida de algunas de estas funciones y sus fallos. Los de mi cabeza estaban bastante cerca de ese programa, muchos de ellos siguiendo el patrón de las convulsiones depresivas. Recuerdo en particular la lamentable casi desaparición de mi voz. Sufrió una extraña transformación, haciéndose a veces muy débil, sibilante y espasmódica — un amigo — observó más tarde que era la voz de alguien de noventa años. La libido también hizo una salida temprana, como lo hace en la mayoría de las enfermedades — es una necesidad superflua del cuerpo cuando se está acosado por la emergencia. Muchas personas pierden todo el apetito; el mío era relativamente normal, pero me encontré comiendo sólo para subsistir: la comida, como todo lo demás en el ámbito de las sensaciones, era completamente insípida. La más angustiante de todas las interrupciones instintivas era la del sueño, junto con una ausencia completa de los sueños.

El agotamiento combinado con la falta de sueño es una tortura rara. Las dos o tres horas de sueño que podía conseguir en la noche eran siempre gracias al Halcion — un problema que merece una atención especial. Desde hace algún tiempo muchos expertos en psicofarmacología han advertido que los tranquilizantes de la familia de las benzodiazepinas, de los cuales Halcion es uno (Valium y Ativan son otros), son capaces de deprimir el ánimo incluso precipitar una depresión mayor. Más de dos años antes de mi ataque, un médico descuidado me había recetado Ativan como una ayuda para dormir, y me dijo sin darle importancia que podía tomarlo con tanta naturalidad como la aspirina. *The Physicians' Desk Reference*, la biblia

farmacológica, revela que la medicina que había estado ingiriendo era (a) tres veces la dosis prescrita normalmente, (b) no es recomendable como un medicamento por más de un mes, y (c) debe utilizarse con especial precaución por la gente de mi edad. En el momento del que estoy hablando ya no estaba tomando Ativan, pero me había vuelto adicto al Halcion y estaba consumiendo grandes dosis. Parece razonable pensar que este era otro factor que contribuía al problema que me afligía. Ciertamente, debería servir como una advertencia a otros.

En todo caso, mis pocas horas de sueño por lo general se terminaban a las tres o cuatro de la mañana, cuando quedaba bostezando mirando la oscuridad, preguntándome y retorciéndome en la devastación que tenía lugar en mi mente, y en espera de la aurora, que por lo general me permitía una febril, siesta sin sueños. Estoy bastante seguro de que fue durante uno de esos trances insomnes que vino a mí el conocimiento —una extraña y chocante revelación, como una de esas verdades metafísicas veladas por mucho tiempo— que esta condición me costaría la vida si continuaba así. Esto debió haber sido justo antes de mi viaje a París. La muerte, como ya he dicho, era ahora una presencia diaria, que soplaba sobre mí en ráfagas frías. Yo no había pensado exactamente cómo vendría mi fin. En resumen, yo seguía manteniendo la idea del suicidio a raya. Pero claramente la posibilidad estaba a la vuelta de la esquina, y yo no tardaría en reunirme cara a cara con ella.

Lo que había empezado a descubrir es que, misteriosamente, y en formas que están totalmente alejadas de la experiencia normal, la llovizna gris de la depresión inducida por el terror adquiere la calidad de dolor físico. Pero no es un dolor inmediatamente identificable, como el de un miembro roto. Puede ser más exacto decir que, a causa de alguna mala pasada, la desesperación juega en el cerebro enfermo habitado por la psique; llega a parecerse a la incomodidad diabólica de ser encarcelado en una habitación fuertemente sobrecalentada.

Y porque no hay brisa que refresque este caldero, porque no hay escape de este confinamiento asfixiante, es completamente natural que la víctima comience a pensar incesantemente en el alivio.

V

Uno de los momentos memorables de *Madame Bovary* es la escena en la que la protagonista busca la ayuda del cura del pueblo. Sintiendo culpable, angustiada, miserablemente deprimida, la adúltera Emma —apuntando hacia un eventual suicidio— tropezando, intenta presionar al abate para que la ayudara a encontrar una manera de salir de su miseria. Pero el sacerdote, un alma simple y no muy brillante, sólo puede tirar de su sotana manchada, gritar distraídamente a sus acólitos, y ofrecer lugares comunes cristianos. Emma continúa su camino en silencio frenética, más allá de la comodidad de Dios o del hombre.

Me sentí un poco como Emma Bovary en mi relación con el psiquiatra que llamaré Dr. Gold, a quien empecé a visitar inmediatamente después de mi regreso de París, cuando la desesperación había comenzado su tamborileo diario despiadado. Nunca antes había consultado a un terapeuta cognitivo y me sentía incómodo, también un poco a la defensiva; mi dolor se había vuelto tan intenso que me parecía bastante improbable que la conversación con otro mortal, incluso uno con experiencia profesional en los trastornos del estado de ánimo, pudiera aliviar la angustia. *Madame Bovary* fue al sacerdote con la misma duda vacilante. Sin embargo, nuestra sociedad está tan estructurada que el doctor Gold, o alguien como él, es la autoridad a la que uno se ve obligado a consultar durante una crisis, y no es del todo una mala idea, ya que el Dr. Gold —entrenado en Yale, altamente calificado—, al menos proporciona un punto focal hacia el que uno puede dirigir las moribundas energías, ofrece consuelo sin demasiadas esperanzas, y se convierte en el receptáculo para un torrente de calamidades durante cincuenta minutos, que también proporciona alivio para la esposa de la víctima.

Sin embargo, aunque yo nunca pondría en duda la eficacia potencial de la psicoterapia en las manifestaciones

iniciales o formas más leves de la enfermedad —o, posiblemente, incluso en las secuelas de un grave ataque— su utilidad en la etapa avanzada que yo estaba tiene que ser prácticamente nula. Mi propósito más específico al consultar al Dr. Gold era obtener ayuda a través de la farmacología —aunque esto también era, por desgracia, una quimera para una víctima tocando fondo en la que me había convertido.

Él me preguntó si yo era suicida, y de mala gana le dije que sí. Sin ser específico —ya que no parecía haber ninguna necesidad de serlo— no le dije que en verdad muchos de los artefactos de mi casa se habían convertido en dispositivos posibles para mi propia destrucción: las vigas del ático (y una o dos de arco exterior) para ahorcarme, el garaje un lugar para inhalar monóxido de carbono, la bañera un recipiente para recibir el flujo de mis arterias abiertas. Los cuchillos de cocina en sus cajones tenían un solo objetivo para mí. La muerte por ataque al corazón parecía particularmente atractiva, absolviéndome de la responsabilidad activa, y había jugado con la idea de neumonía autoinducida —una larga y fría caminata, en mangas de camisa por los bosques lluviosos. Tampoco había pasado por alto un accidente ostensible, al estilo de Randall Jarrell, caminando delante de un camión en la autopista cercana. Estos pensamientos pueden parecer extravagantemente macabros —una broma tensa— pero son genuinos. Son, sin duda, especialmente repugnantes para un ciudadano sano, con su fe puesta en la superación personal. Sin embargo, en verdad esas fantasías espantosas, que hacen que tales personas se estremezcan, son para la mente profundamente deprimida lo que los sueños lascivos son para personas de sexualidad robusta. El Dr. Gold y yo comenzamos a charlar dos veces por semana, pero había poco que pudiera decirle, excepto intentar, en vano, describir mi desolación.

Tampoco podía él decir nada de mucho valor para mí. Sus lugares comunes no eran cristianos, pero, casi tan ineficaces, tomados directamente de las páginas del *Manual Diagnóstico y*

Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana (gran parte del cual, como ya he dicho antes, yo ya había leído), y el consuelo que me ofreció fue un medicamento antidepresivo llamado *Ludiomil*. La píldora me puso nervioso, desagradablemente hiperactivo, y cuando la dosis se aumentó después de diez días, una noche se me cerró la vejiga durante horas. Al informar al Dr. Gold de este problema, me dijo que deberán pasar diez días más para que mi organismo se limpiara de la droga, antes de empezar con una píldora diferente. Diez días para alguien extendido sobre una rejilla de tortura es como diez siglos —y esto sin tener en cuenta el hecho de que cuando se inaugura una nueva píldora deben transcurrir varias semanas antes de que surta efecto, un desarrollo que en todo caso está lejos de ser garantizado.

Esto nos lleva a la cuestión de los medicamentos en general. Se debe dar el debido crédito a la psiquiatría por su lucha continua para tratar la depresión con aliados farmacológicos. El uso del litio para estabilizar los estados de ánimo en la depresión maníaca es un gran logro médico; el mismo fármaco también está siendo empleado con eficacia como un preventivo en muchos casos de depresión unipolar. No puede haber ninguna duda de que en ciertos casos moderados y algunas formas crónicas de la enfermedad (las llamadas depresiones endógenas) los medicamentos han demostrado ser muy valiosos, a menudo alterando el curso de una grave perturbación de forma espectacular. Por razones que aún no están claras para mí, ni los medicamentos ni la psicoterapia fueron capaces de detener mi caída hacia las profundidades. Si se pueden creer las afirmaciones de las autoridades responsables en el campo —incluyendo las afirmaciones hechas por los médicos que he llegado a conocer personalmente y respetar— el desarrollo maligno de mi enfermedad me colocaba en una clara minoría de los pacientes, severamente afectado, cuya aflicción está fuera de control. En cualquier caso, yo no quiero parecer insensible al éxito de los

tratamientos que últimamente han disfrutado la mayoría de las víctimas de la depresión. Especialmente en sus primeras etapas, la enfermedad cede favorablemente ante técnicas tales como la terapia cognitiva — sola, o en combinación con medicamentos — y otras estrategias psiquiátricas en continua evolución. La mayoría de los pacientes, después de todo, no tienen que ser hospitalizados y no intentan suicidarse o terminan haciéndolo. Pero hasta ese día cuando se desarrolle un agente que actúe con rapidez, la fe en la cura farmacológica para la depresión mayor debe seguir siendo provisional. El fracaso de estas pastillas para actuar positiva y rápidamente — un defecto que es ahora el caso general — es algo análogo al fracaso de casi todos los medicamentos para frenar las infecciones bacterianas masivas antes de que los antibióticos se convirtieran en un remedio específico. Y puede ser igual de peligroso.

Así, encontré poco de valor para mencionar en mis consultas con el Dr. Gold. En mis visitas él y yo continuamos intercambiando trivialidades, mi vacilante habla entonces — mi charla, emulando mi manera de caminar, se había desacelerado al equivalente vocal del arrastrar los pies — estoy seguro que era tan aburrida como la suya.

A pesar de los métodos aún vacilantes de tratamiento, la psiquiatría, en un nivel analítico y filosófico, ha contribuido mucho a la comprensión de los orígenes de la depresión. Queda mucho obviamente por aprender (y mucho, sin duda, sigue siendo un misterio, debido a la naturaleza idiopática de la enfermedad, su constante capacidad de intercambio de factores), pero sin duda un elemento psicológico se ha establecido más allá de toda duda razonable, y que es el concepto de *pérdida*.

La *pérdida*, en todas sus manifestaciones, es el punto de referencia de la depresión — en el progreso de la enfermedad y, muy probablemente, en su origen. En una fecha posterior fui persuadido gradualmente de que la pérdida devastadora en la infancia figuraba como una génesis probable de mi propio

desorden; mientras yo monitoreaba mi condición retrógrada, sentí la pérdida por todas partes. La pérdida de la autoestima es un síntoma célebre, y mi propio sentido del *ser*, había desaparecido, junto con cualquier autosuficiencia. Esta pérdida puede degenerar rápidamente en dependencia y de dependencia en temor infantil. Uno teme la pérdida de todas las cosas, todas las personas cercanas y queridas. Existe un profundo temor al abandono. Estar solo en casa, aunque fuera por un momento, me producía pánico y temor intensos.

De las imágenes recuperadas de aquel tiempo, permanece como la más extraña y desconcertante una a la edad de cuatro años y medio, siguiendo a través de un mercado a mi sufrida esposa; ni por un instante podía dejar fuera de mi vista el alma infinitamente paciente que se había convertido en niñera, mamá, confortadora, sacerdotisa, y, lo más importante, confidente — una consejera como una roca central de mi existencia cuya sabiduría superaba con creces la del Dr. Gold. Me atrevería a arriesgar la opinión de que muchas secuelas desastrosas de la depresión podrían evitarse si las víctimas recibieran apoyo, como ella me dio. Pero mientras tanto mis pérdidas nacían y proliferaban. No hay duda de que a medida que uno se acerca a las penúltimas profundidades de la depresión —es decir, justo antes de la etapa en que uno comienza representar su suicidio en lugar de ser su mero espectador— el agudo sentido de pérdida se conecta con un conocimiento de la vida escapando a una velocidad acelerada. Uno desarrolla apegos feroces.

Cosas absurdas —mis gafas de lectura, un pañuelo, un determinado instrumento de escritura— se convirtieron en los objetos de mi demente posesividad. Cada extravío momentáneo me llenaba de una consternación frenética, cada elemento es el recordatorio táctil de un mundo que pronto será borrado.

Noviembre avanzaba, sombrío, crudo y frío. Un domingo, un fotógrafo y sus ayudantes llegaron a tomar fotos para un artículo que sería publicado en una revista nacional. De

la sesión recuerdo muy poco, excepto los primeros copos de nieve del invierno que salpicaban el aire exterior. Recuerdo haber obedecido la petición del fotógrafo para sonreír a menudo. Un día o dos más tarde el director de la revista llamó por teléfono a mi esposa, preguntándole si yo querría someterme a otra sesión. La razón que dio fue que las fotos, incluso las que tenían sonrisas, estaban «*demasiado cargadas de angustia*».

Había llegado entonces a esa fase del trastorno donde todo sentido de esperanza se había desvanecido, junto con la idea de un futuro; mi cerebro, esclavo de sus hormonas ilegales, se había vuelto menos un órgano de pensamiento que un instrumento para registrar, minuto a minuto, diversos grados de su propio sufrimiento. Las mañanas mismas se ponían malas, cuando vagaba letárgico siguiendo mi sueño sintético, pero por la tarde estaba todavía peor, a partir de las tres de la tarde, cuando me embargaba el horror, como un banco de niebla venenosa que se esparcía en mi mente, obligándome a la cama. Quedaba ahí tirado como seis horas, estupefacto y virtualmente paralizado, mirando hacia el techo y esperando por ese momento de la noche, cuando, misteriosamente, la crucifixión se aliviaba lo suficiente para permitirme forzarme a bajar un poco de comida y luego, como un autómata, buscar una o dos horas de sueño nuevamente. ¿Por qué no estaba yo en un hospital?

VI

Durante años había mantenido un cuaderno —no estrictamente un diario, sus entradas eran erráticas y escritas anárquicamente— cuyo contenido no estaba como para ser escudriñado por otros ojos que no fueran los míos. Lo había escondido en mi casa fuera de la vista. No había allí ninguna observación que pudiera escandalizar, lejos de ser lascivas o malas o autoreveladoras, como podría indicar mi deseo de mantener el cuaderno en privado. No obstante, tenía toda la intención de usar el pequeño volumen de forma profesional y luego destruirlo antes de que el día, aún lejano, en que el espectro de la residencia de ancianos estuviera demasiado cerca. A medida que mi enfermedad empeoró, confusamente percibí que si alguna vez decidía deshacerme del cuaderno, ese momento coincidiría con mi decisión de ponerme fin. Y una noche a principios de diciembre ese momento llegó.

Esa tarde había conducido (que ya no podía conducir) a la oficina del Dr. Gold, donde me dijo que había decidido prescribirme el antidepresivo *Nardil*, un medicamento más antiguo que tenía la ventaja de no causar la retención de orina de las otras dos pastillas que me había recetado. Sin embargo, había otros inconvenientes.

El efecto del Nardil probablemente comenzaría a notarse entre cuatro y seis semanas —yo apenas podía creer esto— y tendría que obedecer cuidadosamente ciertas restricciones en la dieta, afortunadamente más bien epicúrea (sin salchicha, sin queso, sin foie gras), con el fin de evitar un choque de enzimas incompatibles que podrían causar un derrame cerebral.

Además, el Dr. Gold, me dijo, con cara seria, que el medicamento en dosis óptima podría tener como efecto secundario la impotencia.

Hasta ese momento, a pesar de que había tenido algunos problemas con su personalidad, yo no había pensado en él como totalmente carente de perspicacia; ahora no estaba del todo

seguro.

Poniéndome yo en los zapatos del Dr. Gold, me pregunté si él pensaba seriamente que este semi-inválido confundido, devastado y desprovisto de juicio, arrastrando los pies y jadeando como un anciano, despertaba cada mañana de su sueño provocado por el Halcion ávido de diversión carnal.

Hubo una cualidad tan incómoda en la sesión de ese día que me fui a casa en un estado particularmente miserable y preparado para la noche. Habían llegado unos cuantos invitados a cenar —algo que yo ni temía ni acogía y que en sí mismo (es decir, en mi indiferencia apática) revela un aspecto fascinante de la patología de la depresión. Esto no tiene que ver con el familiar umbral de dolor, sino un fenómeno paralelo, y que es la probable incapacidad de la psique para absorber el dolor más allá de cierto límite predecible de tiempo. Hay una región en la experiencia del dolor, donde la certeza de alivio permite una resistencia sobrehumana. Aprendemos a vivir con el dolor en mayor o menor grado todos los días, o durante períodos largos de tiempo, pero estamos misericordiosamente más a menudo libres de él que bajo su imperio. Cuando sufrimos molestias graves de carácter físico nuestro condicionamiento nos ha enseñado desde la infancia a hacer adaptaciones a las demandas de dolor —a aceptarlo valientemente o lloriqueando y quejándonos, de acuerdo con nuestro grado personal de estoicismo — pero en cualquier caso, a aceptarlo. Excepto en el intratable dolor terminal, casi siempre hay alguna forma de alivio; esperamos el alivio, ya sea a través del sueño o del Tylenol o de la auto-hipnosis o un cambio de postura o, más a menudo, a través de la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo; abrazamos esta eventual tregua como la recompensa natural, que recibimos por haber estado, de manera temporal, como buenos deportistas e intrépidos sufrientes, como porristas de corazón optimistas por la vida.

En la depresión esta fe en la liberación, en la restauración definitiva, está ausente. El dolor es implacable, y lo que hace la

condición intolerable es el conocimiento previo de que ningún remedio está en camino —no en un día, una hora, un mes, o un minuto. Si hay un alivio leve, se sabe que es sólo temporal; y luego seguirá más dolor.

Es la *desesperación*, incluso más que el dolor lo que aplasta el alma. Así, la toma de decisiones de la vida cotidiana no implica, como en los asuntos normales, cambiar de una situación molesta a otra menos molesta —o de la incomodidad a la comodidad relativa, o del aburrimiento a la actividad—, sino pasar del dolor al dolor. Uno no abandona, aunque sea brevemente, la propia cama de clavos, sino que está unido a ella dondequiera que uno vaya. Y esto se traduce en una dramática experiencia —una que he llamado, tomándola prestada de la terminología militar, la situación de *«los heridos que pueden caminar»*. Porque en prácticamente cualquier otra enfermedad grave, un paciente que siente una devastación similar sería acostado en una cama, posiblemente, sedado y conectado a tubos y cables de sistemas de soporte vital, pero por lo menos en una postura de reposo y en un entorno aislado. Su invalidez sería necesaria, incuestionable y obtenida honorablemente. Sin embargo, la víctima de depresión no tiene esa opción y, por tanto, se encuentra, al igual que una víctima de guerra, empujada en las situaciones sociales y familiares más intolerables. Allí debe, a pesar de la angustia que devora su cerebro, presentar un rostro que se aproxime al que se asocia con la clase de evento y la compañía. Debe tratar de mantener una pequeña charla, responder a las preguntas, y con conocimiento asentir y fruncir el ceño y, si Dios lo ayuda, incluso sonreír. Pero es una prueba feroz intentar hablar unas pocas palabras sencillas.

Esa tarde de diciembre, por ejemplo, podría haber permanecido en la cama como de costumbre durante esas peores horas, o aceptar la cena que mi esposa había organizado en la planta baja. Pero la idea misma de tomar una decisión constituía un reto intelectual.

Cualquier camino era una tortura, y elegí la cena, no por algún mérito particular, sino a través de la indiferencia a lo que yo sabía que iba a ser una terrible experiencia, indistinguible del horror de estar inmovilizado por la niebla. En la cena fui casi incapaz de hablar, pero el cuarteto de huéspedes, que eran buenos amigos, eran conscientes de mi enfermedad y cortésmente ignoraban mi mutismo catatónico.

Luego, después de la cena, sentado en la sala de estar, experimenté una convulsión interna curiosa que puedo describir solamente como la desesperación más allá de la desesperación. Salió de la noche fría; nunca pensé que tal angustia fuera posible. Mientras mis amigos charlaban en voz baja frente al fuego me excusé y fui arriba, donde saqué mi cuaderno de notas de su lugar especial. Luego me fui a la cocina y con una brillante claridad — la claridad de quien sabe que está involucrado en un rito solemne — observé todas las leyendas de las marcas, bien destacadas, en los artículos que comencé a utilizar para deshacerme del volumen: abrí un rollo nuevo de toallas de papel marca *Viva* para envolver el cuaderno, y usé cinta *Scotch* para fijar el envoltorio, para colocarlo todo dentro de una caja de cereal *Raisin Bran* vacía; puse el paquete profundo dentro del cubo de la basura, que sería vaciado a la mañana siguiente.

El fuego lo hubiera destruido más rápido, pero en la basura simbolizaba una auto aniquilación correspondiente, como siempre, a la fecunda auto humillación de la melancolía. Sentí mi corazón golpeando salvajemente, como el de un hombre frente a un pelotón de fusilamiento, y sabía que había tomado una decisión irreversible.

Un fenómeno que varias personas han señalado, cuando están bajo una depresión profunda es la sensación de estar acompañado por un segundo ser, un observador espectral que, sin compartir la demencia de su doble, es capaz de ver con curiosidad desapasionada cómo su compañero lucha contra la catástrofe que se aproxima, o decide aceptarla.

Hay una cualidad teatral en todo esto, y durante los días siguientes, a medida que impasiblemente me preparaba para la extinción, no podía quitarme de encima la sensación de melodrama — un melodrama en el que yo, la futura víctima de auto-asesinato, era a la vez el actor solitario y el único miembro de la audiencia. Yo aún no había elegido el modo de mi partida, pero sabía que ese paso vendría después, y pronto, tan ineludible como la noche.

Me observé a mí mismo con terror y fascinación mezclados, cuando comencé a hacer los preparativos necesarios: ir a ver a mi abogado en el pueblo cercano — reescribir mi testamento — y gastar parte de un par de tardes en un intento confuso para dejar a la posteridad una carta de despedida. Resultó que la elaboración de una nota de suicidio, cuya necesidad me obsesionaba, era la tarea de escritura más difícil que nunca hubiera abordado. Había demasiada gente para reconocer, para agradecer, para dejar ramos de flores de despedida. Y, finalmente, no podía manejar el canto fúnebre con la solemnidad requerida; había algo que me pareció casi cómicamente ofensivo en la pomposidad de un comentario como: «Desde hace algún tiempo he sentido en mi trabajo una psicosis creciente que es, sin duda, un reflejo de la cepa psicótica que ha arruinado mi vida» (esta es una de las pocas líneas que recuerdo textualmente), así como algo degradante, en la perspectiva de un testamento, que yo deseaba infundir con por lo menos un poco de dignidad y elocuencia, reducida a un tartamudeo exhausto de disculpas inadecuadas y explicaciones interesadas. Debería haber usado como ejemplo la declaración mordaz del escritor italiano Cesare Pavese, que al partir, escribió simplemente:

«No más palabras.

Un acto, nunca voy a escribir de nuevo».

Pero incluso algunas palabras llegaron a parecerme también pura palabrería y destruyó todos mis esfuerzos, resolviéndome a partir en silencio. Era tarde esa noche

terriblemente fría, cuando supe que yo no existiría a través del día siguiente, me senté en la sala de estar abrigado para protegerme del frío; algo había sucedido a la estufa. Mi esposa se había ido a la cama, y me vi obligado a ver la cinta de una película en la que una joven actriz, que había estado en una obra mía, actuaba una pequeña parte. En un momento de la película, que transcurría en Boston a finales del siglo XIX, los personajes se movían por el pasillo de un conservatorio de música, detrás de cuyas paredes desde músicos invisibles, llegaba una voz de contralto, un repentino pasaje elevado de la *Rapsodia para alto* de Brahms.

Este sonido, al cual como toda la música —de hecho, como todo placer— yo había sido insensible por varios meses, atravesó mi corazón como una daga, y en una veloz inundación de recuerdos pensé en todas las alegrías que la casa había conocido: los niños que habían corrido a través de sus habitaciones, los festivales, el amor y el trabajo, el sueño ganado honradamente, las voces y la conmoción ágil, la tribu perenne de gatos y perros y las aves, «*risas, aptitud y suspiros, y faldas y rizos*» Todo esto, me di cuenta, era más de lo que jamás podría abandonar, incluso lo que me había propuesto deliberadamente hacer era más de lo que podía infligir a esos recuerdos, y sobre aquellos tan cerca de mí, a quienes estaban ligados esos recuerdos. Y tan poderosamente también me di cuenta de que no podía cometer esta profanación en mí mismo.

Recurrí a un último destello de cordura para percibir las terribles dimensiones aterradoras del mortal predicamento en que había caído. Desperté a mi esposa y pronto hizo las llamadas telefónicas. Al día siguiente, fue admitido en el hospital.

VII

Fue el Dr. Gold, actuando como mi médico de cabecera, quien fue llamado para extender la orden de internación en el hospital. Curiosamente, él me había dicho una vez o dos veces durante nuestras sesiones (y después de que yo hubiera abordado más bien vacilante la posibilidad de hospitalización) que debería tratar de evitar el hospital a toda costa, debido al estigma que podría sufrir.

Tal comentario pareció entonces, como ahora, muy equivocado; yo pensaba que la psiquiatría había avanzado mucho más allá del punto en que el estigma se asociaba a cualquier aspecto de la enfermedad mental, incluyendo la hospitalización. Este refugio, difícilmente declarado lugar agradable, es una instalación donde los pacientes todavía pueden ir cuando los fármacos fallan, como sucedió en mi caso, y donde el tratamiento puede ser considerado como una extensión prolongada, en un entorno diferente, de la terapia que comenzó en un consultorio como el del Dr. Gold.

Es imposible decir, por supuesto, cuál habría sido el enfoque de otro médico; si también hubiera desalentado la ruta al hospital.

Muchos psiquiatras, que simplemente no parecen ser capaces de comprender la naturaleza y profundidad de la angustia a la que sus pacientes están sometidos, mantienen su lealtad obstinada a los productos farmacéuticos, en la creencia de que con el tiempo el paciente responderá a los mismos, y así evitarán el sombrío entorno del hospital. El Dr. Gold era de tal tipo, parece claro, pero en mi caso se había equivocado; estoy convencido de que debería haber sido internado varias semanas antes. Porque, de hecho, el hospital fue mi salvación, y es algo paradójico que en este lugar austero, con sus puertas cerradas y enrejadas, con sus desolados pasillos verdes —con las ambulancias chillando día y noche diez pisos más abajo— yo encontrara el descanso, el apaciguamiento de la tempestad en

mi cerebro, que no pude hallar en mi tranquila casa de campo.

Esto es en parte el resultado del aislamiento, de la seguridad, de ser removido a un mundo en el que el impulso de coger un cuchillo y clavárselo en el pecho desaparece ante el nuevo descubrimiento, rápidamente evidente incluso para el difuso cerebro de la depresión, que el cuchillo con el que está tratando de cortar su espantoso bistec suizo es de plástico flexible. Pero el hospital también ofrece el dulce trauma, curiosamente gratificante de la repentina estabilización —una transferencia del entorno demasiado familiar del hogar, donde todo es ansiedad y discordia, hacia una detención ordenada y benigna donde la única tarea es tratar de ponerse bien. Para mí los curadores reales fueron el aislamiento y tiempo.

VIII

El hospital fue una estación de paso, un purgatorio.

Cuando entré en el lugar, mi depresión parecía tan profunda que, en opinión de algunos miembros del personal, era un candidato a la TEC, *terapia de electro-shock convulsivo*, como es más conocida. En muchos casos es un remedio eficaz —que una vez mejorado, ha hecho una reaparición respetable, en general, superando el descrédito medieval que le fue endilgado en otros tiempos— pero es claramente un procedimiento drástico que uno quiere evitar. Lo eludí porque empecé a ponerme bien, gradualmente pero sin pausa. Me quedé sorprendido al descubrir que las fantasías de autodestrucción, prácticamente desaparecieron a los pocos días de haberme registrado, y este es, de nuevo, un testimonio del efecto pacificador que el hospital puede brindar; su valor inmediato como un santuario donde la paz puede volver a la mente.

Debo añadir unas palabras de precaución final en referencia al *Halcion*.

Estoy convencido de que este tranquilizante es responsable de al menos exagerar hasta un punto intolerable las ideas suicidas que me habían poseído antes de ingresar al hospital. La evidencia empírica que me convenció de esto la obtuve a partir de una conversación que tuve con un psiquiatra sólo horas después de entrar en la institución. Cuando él me preguntó lo que estaba tomando para dormir y la dosis, le dije 0,75 mg de Halcion; en su rostro se dibujó una sombra. Me dijo enfáticamente que esa era tres veces la dosis hipnótica normalmente prescrita, y una cantidad especialmente contraindicada para alguien de mi edad. Me lo cambió de inmediato por Dalmane, otro hipnótico, un primo de acción más prolongada, que resultó al menos tan eficaz como el Halcion para ponerme a dormir; pero lo más importante, es que me di cuenta de que poco después el impulso de mis ideas suicidas

mermó y luego desapareció.

Hay mucha evidencia acumulada recientemente que señala al Halcion (cuyo nombre técnico es *triazolam*) como un factor causal en la producción de la obsesión suicida y otras aberraciones del pensamiento en personas susceptibles.

A causa de estas reacciones el Halcion ha sido prohibido en los Países Bajos, y en EEUU debe ser monitoreado por lo menos con más cuidado. No recuerdo que el Dr. Gold cuestionara la dosis excesivamente fuerte que él sabía que yo estaba tomando; es de suponer que no había leído las advertencias en el *Physicians Desk Reference*. También mi propio descuido tuvo la culpa en la ingestión de una sobredosis de este tipo. Atribuyo esa falta de cuidado a la floja declaración que me había dado varios años antes, cuando empecé a tomar *Ativan* a instancias de un médico descuidado que me dijo que yo podía tomar, sin daño, tantas pastillas como deseara. Uno se estremece al pensar en el daño que tal prescripción promiscua de estos tranquilizantes potencialmente peligrosos puede estar creando en los pacientes de todo el mundo. En mi caso el Halcion, por supuesto, no fue un villano independiente —ya me dirigía hacia el abismo—, pero creo que sin él pudiera ser que no cayera tan bajo.

Me quedé en el hospital durante casi siete semanas. No todo el mundo responde como yo lo hice; la depresión, hay que insistir constantemente, presenta tantas variaciones y tiene tantas facetas sutiles —en definitiva depende de la persona, tanto en la causalidad como en la respuesta— que la panacea de una persona podría ser una trampa para otra. Pero sin duda los hospitales (y, por supuesto, estoy hablando de los buenos, que son muchos) deben ser rescatados de su reputación amenazante, no debería ser tan a menudo considerado como último recurso. Difícilmente el hospital sea un lugar de vacaciones; aquel en el que me alojé (tuve el privilegio de estar en uno de los mejores del país) brindaba el brutal aburrimiento de cualquier hospital. Si además se instalan en un piso, como en

el mío, catorce o quince hombres y mujeres de mediana edad en la agonía de la melancolía con manía suicida, entonces uno puede imaginar un ambiente bastante desprovisto de risas.

Para mí esto no era mejorado por la comida, peor que la de los aviones o por el vistazo del mundo exterior: *Dinastía*; *Knots Landing* y el noticiero nocturno de la CBS que pasaban todas las noches en la vacía sala de recreo. A veces era consciente de que el lugar donde yo había encontrado refugio era un manicomio por lo menos más suave y amable que el que yo había dejado. En el hospital participé de lo que podía ser, a regañadientes, un favor de la depresión: su definitiva capitulación.

Incluso aquellos para quienes cualquier tipo de terapia es un ejercicio inútil, todavía pueden mirar adelante hacia la eventual culminación de la tormenta. Si sobreviven a la tormenta misma, su furia casi siempre se desvanece y luego desaparece. Misteriosa en su llegada, misteriosa en su partida, la aflicción sigue su curso, y uno encuentra la paz.

A medida que fui mejorando encontré distracciones en la rutina del hospital, con sus propias comedias institucionalizadas.

La terapia de grupo, según me han dicho, tiene cierto valor; yo jamás quisiera menoscabar cualquier procedimiento que haya demostrado ser eficaz para ciertos individuos. Pero la terapia de grupo no hizo nada por mí, excepto enervarme, posiblemente debido a que estaba supervisado por un psiquiatra joven odiosamente engreído, con una barba oscura con forma de pala (*der junge Freud?*)³. En su intento de hacernos toser las semillas de nuestra miseria era alternativamente condescendiente e intimidante, y en ocasiones redujo a una o dos de las pacientes femeninas, tan tristes en sus kimonos y rulos, a lo que yo estoy seguro que él consideraba como lágrimas satisfactorias. (Creo que el resto del personal

³ ¿Del joven Freud?, en alemán en el original. (NdT)

psiquiátrico resultó ejemplar en su tacto y compasión.) El tiempo transcurre lentamente en el hospital, y lo mejor que puedo decir de la terapia de grupo es que se trataba de una manera de ocupar las horas.

Más o menos lo mismo puede decirse de la terapia artística, que se orienta hacia el infantilismo. Nuestra clase estaba a cargo de una joven delirante con una sonrisa fija infatigable, que claramente fue formada en una escuela que ofrece cursos de enseñanza de arte para enfermos mentales. Ni siquiera un maestro de niños retrasados muy pequeños podría haber sido obligado a otorgar, sin instrucción deliberada, tales risitas y arrullos orquestados. Desenrollando largos rollos de papel mural resbaladizo, ella nos decía que tomáramos nuestros crayones e hiciéramos dibujos ilustrativos de los temas que nosotros mismos hubiéramos elegido. Por ejemplo: *Mi Casa*. Obedecí con humillante ira; dibujé un cuadrado, con una puerta y cuatro ventanas bizcas, una chimenea en la parte superior emitiendo un arabesco de humo. Ella me colmó de elogios, y al avanzar las semanas mi salud mejoró, también mi sentido de la comedia. Comencé a incursionar felizmente con plastilina de colores, esculpiendo al principio un pequeño cráneo verde horrible con los dientes al descubierto, ante la cual nuestra maestra consideró una espléndida réplica de mi depresión.

Entonces procedí, a través de las etapas intermedias de recuperación, con una cabeza de querubín de color rosado y con una sonrisa de "*have-a-nice-day*".⁴ Coincidiendo como lo hizo con el momento de mi alta, esta creación realmente alegró a mi instructora (de quien me había convertido en aficionado a pesar de mí mismo), ya que, según me dijo, era emblemático de mi recuperación y por lo tanto un ejemplo más del triunfo sobre la enfermedad mediante la terapia artística.

Esto fue a principios de febrero, y aunque todavía estaba débil supe que había salido a la luz. Ya no me sentía una cáscara

⁴ Carita feliz. (NdT)

sino un cuerpo con un poco de dulces jugos recorriéndolo de nuevo. Tuve mi primer sueño en muchos meses, confuso, pero hasta el día hoy imperecedero, con una flauta en alguna parte, y un ganso salvaje, y una bailarina.

IX

Por mucho, la gran mayoría de las personas que pasan por la depresión más severa sobreviven, y viven por lo menos tan felices como sus congéneres no afectados. Salvo por lo terrible de ciertos recuerdos que deja, la depresión aguda inflige pocas heridas permanentes. Hay un tormento de Sísifo en el hecho de que un número muy grande —casi la mitad— de los que devastó una vez son golpeados de nuevo; la depresión tiene el hábito de la recurrencia. Pero la mayoría de las víctimas que vive a través de estas recaídas, a menudo las afronta mejor porque se ha vuelto psicológicamente más apta por la experiencia del pasado para enfrentar al ogro. Es de gran importancia que a las personas que sufren un ataque, tal vez por primera vez, se les diga —se les convenza, más bien— que la enfermedad seguirá su curso y que van a salir adelante. Un arduo trabajo este; alentar con un «*¡Arriba el ánimo!*» desde la seguridad de la orilla a una persona que se ahoga es equivalente a un insulto, pero se ha demostrado una y otra vez que si el estímulo es suficientemente obstinado y el apoyo igualmente comprometido y apasionado —el peligro casi siempre se puede salvar. La mayoría de la gente en las garras de la depresión en sus formas más espantosas está, por el motivo que sea, en un estado de desesperanza irrealista, desgarrada por males exagerados y amenazas mortales que no tienen ningún sustento en hechos reales. Puede requerir por parte de amigos, amantes, familiares, admiradores, una devoción casi religiosa para persuadir a las víctimas de la pena de la vida, la cual está tan a menudo en conflicto con el sentido de su propia inutilidad, pero esa devoción ha evitado innumerables suicidios.

Durante el mismo verano de mi achaque, un íntimo amigo mío —un columnista de un periódico célebre— fue hospitalizado por una severa depresión maníaca. Para el tiempo en que había comenzado mi caída otoñal, mi amigo se había recuperado (en gran parte debido al litio, pero también, en las

secuelas, a la psicoterapia), y estábamos en contacto por teléfono casi todos los días. Su apoyo fue incansable y no tiene precio. Fue él quien me mantuvo amonestando que el suicidio era «*inacceptable*» (él había sido intensamente candidato al suicidio), y también fue él quien trazó la perspectiva de que ir al hospital no era tan tremendo e intimidante. Todavía recuerdo su preocupación con inmensa gratitud.

La ayuda que me dio, dijo más tarde, había sido una continuación de la terapia para él, lo que demuestra que, si no otra cosa, la enfermedad engendra un durable compañerismo.

Después que empecé a recuperarme en el hospital se me ocurrió preguntarme —por primera vez con algún interés realmente serio—, por qué había sido visitado por tal calamidad. La literatura psiquiátrica sobre la depresión es enorme, teoría tras teoría sobre la etiología de la enfermedad proliferan en abundancia, como las hay sobre la muerte de los dinosaurios o el origen de los agujeros negros.

El mismo número de hipótesis es un testimonio del casi impenetrable misterio de la enfermedad. En cuanto al mecanismo desencadenante —lo que he llamado la *crisis manifiesta*— ¿puedo estar realmente satisfecho con la idea de que la retirada brusca del alcohol comenzó la caída? ¿Qué pasa con otras posibilidades —el hecho arisco, por ejemplo, que casi al mismo tiempo que fui afligido cumplí los sesenta, ese hito descomunal de la mortalidad? ¿O podría ser por una vaga insatisfacción por la forma en que avanzaba mi trabajo —el inicio de la inercia que me ha poseído una y otra vez durante mi vida de escritor, y me ha hecho hosco y disconforme— también me había perseguido con más fuerza que nunca durante ese período, magnificando de alguna manera la dificultad con el alcohol? Preguntas irresolubles, quizás.

En todo caso estas cuestiones me interesan menos que la búsqueda de los orígenes tempranos de la enfermedad. ¿Cuáles son los eventos olvidados o enterrados que sugieren una explicación definitiva para la evolución de la depresión y su

posterior floración en la locura? Hasta el ataque de mi propia enfermedad y su desenlace, nunca di mucha importancia a mi trabajo en términos de su relación con el inconsciente — un área de investigación que pertenece a los detectives literarios. Pero después de haber retornado a la salud y ser capaz de reflexionar sobre el pasado, a la luz de mi terrible experiencia, comencé a ver claramente cómo la depresión se había aferrado a los bordes exteriores de mi vida durante muchos años.

El suicidio ha sido un tema recurrente en mis libros y tres de mis personajes principales se suicidaron. Al releer, por primera vez en años, las secuencias de mis novelas —pasajes donde mis heroínas han descendido tambaleantes por el sendero hacia la fatalidad— me quedé helado al percibir la precisión con que había creado el paisaje de la depresión en las mentes de estas jóvenes mujeres, describiendo con lo que sólo podría ser el instinto, un subconsciente ya irritado por alteraciones del estado de ánimo, el desequilibrio psíquico que les llevó a la destrucción.

Así, la depresión, cuando finalmente llegó a mí, no era en realidad tan ajena, ni siquiera una visitante totalmente sin aviso; había estado golpeando a mi puerta durante décadas.

La condición mórbida procedió, he llegado a creer, de mis primeros años —de mi padre, que combatió al monstruo durante gran parte de su vida, y había sido hospitalizado en mi adolescencia después de una desalentadora espiral descendente que, en retrospectiva, era muy parecía a la mía. Las raíces genéticas de la depresión parecen ahora estar más allá de la controversia. Pero estoy convencido de que un factor aún más significativo fue la muerte de mi madre cuando yo tenía trece años; este hecho traumático y dolor temprano —la muerte o desaparición de uno de los padres, especialmente la madre, antes o durante la pubertad aparece repetidamente en la literatura sobre la depresión como un trauma a veces propenso a crear un caos emocional casi irreparable. El peligro es especialmente evidente si el joven se ve afectado por lo que se

ha denominado *el duelo incompleto* —es decir, que ha sido incapaz de lograr la catarsis de la pena, por lo que lleva dentro de sí, a través de los años, una carga insoportable de rabia y culpa, y no sólo dolor reprimido, son parte y se convierten en las semillas potenciales de auto-destrucción.

En un nuevo libro esclarecedor sobre el suicidio, *Self Destruction in the Promised Land*, Howard I. Kushner, quien no es psiquiatra sino historiador social, argumenta persuasivamente a favor de esta teoría del duelo incompleto y utiliza a Abraham Lincoln como un ejemplo.

Mientras que los estados melancólicos de Lincoln son leyenda, es mucho menos conocido que en su juventud estuvo a menudo en un torbellino suicida y estuvo más de una vez a punto de hacer un atentado contra su propia vida. El comportamiento parece directamente relacionado con la muerte de la madre de Lincoln, Nancy Hanks, cuando él tenía nueve años, y agravado por el dolor inexpresado por la muerte de su hermana, diez años más tarde. Trazando puntos de vista de la crónica del doloroso éxito de Lincoln para evitar el suicidio, Kushner establece un caso convincente para la idea de la pérdida temprana precipitando el comportamiento auto-destructivo. También, auspiciosamente, para convertir ese mismo comportamiento en una estrategia a través de la cual la persona involucrada se enfrenta con su culpa y rabia, y triunfa sobre el deseo de muerte. Dicha conciliación puede ser entrelazada con la búsqueda de la inmortalidad —en el caso de Lincoln, no menos que la de un escritor de ficción, para vencer a la muerte por medio del trabajo honrado por la posteridad.

Así que si esta teoría de duelo incompleto tiene validez, y creo que la tiene, y si también es cierto que en las profundidades más bajas de la conducta de un suicida uno está todavía inconscientemente luchando con inmensas pérdidas y al mismo tiempo de superar todos los efectos de su devastación, entonces mi propia evitación de la muerte pudo haber sido un homenaje tardío a mi madre. Yo sé que en aquellas últimas horas, antes de rescatarme a mí mismo luego de escuchar ese pasaje de la *Rapsodia para alto* —la cual le había oído cantar— ella había estado en gran medida de mi mente.

X

En el final de una de las primeras películas de Ingmar Bergman, *Through a Glass Darkly*, una mujer joven experimenta el abrazo de lo que parece ser una profunda depresión psicótica, y tiene una alucinación aterradora.

Anticipando la llegada de una ligera visión trascendente y salvífica de Dios, ve en su lugar la forma temblorosa de una araña monstruosa que está tratando de violar su sexualidad. Es un instante de horror y de verdad quemante. Sin embargo, incluso en esta visión de Bergman (quien ha sufrido cruelmente de depresión), hay un sentido de que todo su consumado arte ha caído de alguna manera en una verdadera rendición ante la atroz fantasmagoría de su ahogada mente.

Desde la antigüedad —en el lamento torturado de Job, en los coros de Sófocles y Esquilo— los cronistas del espíritu humano han estado luchando con un vocabulario que pueda dar una expresión adecuada a la desolación de la melancolía. A través de la historia de la literatura y el arte, el tema de la depresión se ha quedado como un hilo durable de dolor —desde el soliloquio de Hamlet a los versos de Emily Dickinson y Gerard Manley Hopkins, de John Donne a Hawthorne y Dostoievski y Poe, Camus y Conrad y Virginia Woolf. En muchos de los grabados de Albrecht Dürer hay descripciones desgarradoras de su propia melancolía; las maníacas estrellas rodantes de Van Gogh son los precursores de la caída del artista en la demencia y la extinción del yo. Es un sufrimiento que muchas veces tiñe la música de Beethoven, de Schumann y Mahler, e impregna las cantatas más oscuras de Bach. La vasta metáfora que más fielmente representa esta terrible experiencia insondable, cómo siempre, es la de Dante, y sus líneas del todo —demasiado— familiares, todavía arrestan la imaginación con su augurio de lo incognoscible, la negra lucha por venir:

Nel mezzo del cammin di nostra vita

*mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita..*⁵

Uno puede estar seguro de que estas palabras han sido más de una vez empleadas para conjurar los estragos de la melancolía, pero su presentimiento sombrío ha eclipsado a menudo las últimas líneas de la parte más conocida de ese poema, con su evocación de la esperanza. Para la mayoría de aquellos que la han experimentado, el horror de la depresión es tan abrumador como para ir bastante más allá de su expresión, de ahí el sentido frustrante de inadecuación que se encuentra en el trabajo, incluso de los más grandes artistas. Pero en la ciencia y el arte, la búsqueda de una representación clara de su significado debe seguir adelante, el cual a veces, por los que la han conocido, es un simulacro de todo el mal de nuestro mundo: de nuestra cotidiana discordia y caos, de nuestra irracionalidad, de la guerra y el crimen, de la tortura y la violencia, de nuestro impulso hacia la muerte y nuestro escape de sus garras en el intolerable equilibrio de la historia. Si nuestras vidas no tienen otra configuración más que esta, deberíamos desear, y tal vez merezcamos, perecer; si la depresión no tiene terminación, entonces el suicidio sería, en efecto, el único remedio. Pero no es necesario emitir un juicio para subrayar la verdad de que la depresión no es la aniquilación del alma; hombres y mujeres que se han recuperado de la enfermedad —y son innumerables— dan testimonio de lo que es probablemente su única gracia salvadora: es conquistable.

Para aquellos que han vivido en el bosque oscuro de la depresión, y conocido su agonía inexplicable, su regreso desde el abismo no es diferente al ascenso del poeta, caminando hacia arriba y hacia arriba desde las negras profundidades del

⁵ [*En medio del camino de nuestra vida
me encontré por una selva oscura,
porque la recta vía estaba perdida.*]

infierno y al fin emerger en lo que vio como «*el brillante mundo*». Entonces, el que ha sido restaurado a la salud casi siempre ha sido restaurado a la capacidad para la serenidad y la alegría, y esto puede ser suficiente indemnización por haber soportado la desesperación más allá de la desesperación.

E quindi uscimmo a riveder le stelle. ⁶

SOBRE EL AUTOR⁷

William Styron es el autor de Tendidos en la oscuridad, La larga marcha, Set This House on Fire, Las confesiones de Nat Turner, La decisión de Sophie, y Este polvo silencioso. Fue galardonado con el Premio Pulitzer, el American Book Award, la Medalla Howells, y la Medalla Edward MacDowell.

Él vive en Roxbury, Connecticut, y Vineyard Haven, Massachusetts.

⁶ «Y otra vez contemplamos las estrellas». (Inferno), último verso del *Inferno* [XXXIV, 139] de *La Divina Commedia* de Dante Alighieri

⁷ Escrito en 1989. El autor murió en 2006 en su casa de Marthas's Vineyard.

Nota del traductor

Descubrí el título de este libro al leer la biografía de Christopher Hitchens, en el capítulo dedicado a Ivonne⁸. Mientras lo rastreaba en Internet, descubrí que mucha gente lo buscaba y mostraba decepción por el hecho de que la versión castellana en papel tampoco estuviera disponible. No creo que haya más celo protector de los derechos de autor en los países de habla hispana, me parece que hay más vagancia. Pero también hay que mencionar que la industria editorial de habla hispana traduce y aprovecha obras que en otros idiomas están liberadas. En inglés fue fácil bajar esta sin costo y libre de derechos, y dado que no es extensa, la traduje yo mismo y creo que se deja leer.

Es evidente que la depresión no es un fenómeno fácilmente descriptible, pero este libro ayuda a entenderla. Los ejemplos de la central telefónica que se inunda y de la habitación sobrecalentada son excelentes, haciendo hincapié en que la desesperación proviene de estar convencido de que su sufrimiento es *eterno*.

El autor se refiere muchas veces a la depresión como un *monstruo* y a los enfermos como *víctimas*. Es sólo una forma de

⁸ Hitch-22; memorias, Ed. Sudamericana (2011) pag. 45 En el pie de página dice:

«En esa cena nos atendía un joven de rostro granujiento, cabello descuidado y conducta espantosamente pegajosa. Al devolver la tarjeta de crédito de Bill, comentó que el nombre era casi el mismo que el de un escritor famoso, Bill no dijo nada. Atonalmente el joven continuó: "Se llama William Styron". Dejé el asunto a Bill, que de nuevo esperó hasta que el chico dijo con naturalidad: "Bueno, el libro de ese tío me salvó la vida". En ese momento Bill lo invitó a sentarse y quedó finalmente convencido de que estaba en la misma mesa que el autor de *Esa visible oscuridad*. Parecía la escena de una transformación. Con voz entrecortada nos contó cómo había buscado y encontrado la ayuda que necesitaba. "¿Esto te pasa mucho?", le pregunté más tarde a Styron. "Todo el tiempo. Hasta me llama la policía y me pide que me ponga y hable con el tío que quiere saltar."

expresarse, no parece lógico pretender que la depresión es algo exterior que ataca a la mente y de lo cual esta última necesita defenderse. El mensaje que transmite es *esperanza*, y es lo más valioso.

P.E.Y

7/7/2014

